

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN ESPECIAL-LOGOPEDIA

MATERIAL DOCENTE EN OPCIÓN AL TÍTULO DE MÁSTER EN ATENCIÓN LOGOPÉDICA INTEGRAL

TÍTULO: La estimulación prenatal de la comunicación oral en el poblado Siboney

AUTOR: Lic. Freddy Matos Ramos

TUTOR: Dr. C. Héctor Núñez Guzmán

2023

Agradecimientos

Ante todo a mi familia que me apoyan de forma incondicional por su paciencia y comprensión por permitir utilizar el tiempo y los recursos en disposición de mi superación personal, durante este periodo dios me dio algo divino y hermoso mi cuarta hija Liett Nicelis que es mi motor impulsor su sonrisa matutina me llena de fuerzas así como mi esposa Surelis que se ha convertido en mi mayor felicidad y es la que cuida de mí y está en los mejor y peores momentos de mi vida en estos últimos tiempos ahora no tengo como agradecerle a mi madre querida por ser de tanta ayuda y no hay palabras para describir su amor, agradecerle a mi hermana y mis sobrinos que están al tanto de mi superación con un apoyo incondicional hacia mí. Es importante resaltar a mis profesores de Tecnología de la Salud y a los profesores de la Maestría en Atención Logopédica Integral en especial a M. Sc. Miladis Fornaris Méndez y mi tutor Dr. C. Héctor Núñez Guzmán así como al colectivo de trabajo de la Escuela Primaria Antonio Boizán Barrientos y el Policlínico XX Aniversario por su ayuda en mi investigación gracias y que dios les de todo lo que me han brindado el doble.

Síntesis

En esta investigación se reconoce la significación de la estimulación prenatal de la comunicación y la necesidad de brindar una orientación familiar oportuna y certera tanto a la embarazada como a sus familiares y su objetivo está encaminado a contribuir a la capacitación del personal que interviene en la primera infancia. En él se tiene en cuenta la influencia de los médicos, enfermera y ejecutores del INDER del programa Educa a tu Hijo, en dicha labor, además, se encuentran reflexiones, comentarios, acciones y técnicas, con el propósito de elevar la calidad de la orientación para que la familia potencie la estimulación de la comunicación desde la gestación del poblado de Siboney. Se da a conocer los métodos y ejercicios a utilizar en la estimulación del lenguaje en la etapa gestacional, así como los beneficios que aporta la estimulación desde el punto de vista preventivo en esta etapa.

Palabras Clave: estimulación prenatal; estimulación del lenguaje; etapa gestacional; programa Educa a tu Hijo

Synthesis

This research recognizes the significance of prenatal stimulation of communication and the need to provide timely and accurate family guidance to both the pregnant woman and her relatives and its objective is aimed at contributing to the training of personnel involved in the first childhood. It takes into account the influence of the doctors, nurses and executors of the INDER of the Educate your Child program, in this work, in addition, reflections, comments, actions and techniques are found, with the purpose of raising the quality of the orientation so that the family promotes the stimulation of communication from the gestation of the town of Siboney. The methods and exercises to be used in the stimulation of language in the gestational stage are disclosed, as well as the benefits that stimulation provides from the preventive point of view at this stage.

Keywords: prenatal stimulation; language stimulation; gestational stage; Educate your child program.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1

DESARROLLO. 8

Epígrafe 1: Estado actual del proceso de orientación familiar para la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal 8

Epígrafe 2: Fundamentos teóricos del manual interdisciplinario para la orientación familiar en la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal. 12

2.1 Proceso de orientación familiar. Fundamentos teóricos. 12

2.2 Fundamentos teórica de estimulación prenatal. 15

2.3. La interdisciplinariedad. 30

Epígrafe 3: Manual de estimulación de la comunicación oral en la etapa gestacional. 31

Epígrafe 4 Validación de la propuesta. 57

CONCLUSIONES 60

RECOMENDACIONES 61

INTRODUCCIÓN

El nacimiento de un niño ocasiona cambios y reestructuración de las funciones de los miembros de la familia. Para ello, es vital no solo que se conozcan a sí mismos y aprovechen sus potencialidades para tomar decisiones sabias que repercutan favorablemente en sus interacciones sociales, sino también que ejerzan el control sistemático, consecutivo y regulador de las interacciones sociales que se establecen en su seno, con la consiguiente satisfacción de las necesidades afectivas, materiales y espirituales.

Al respecto, las más diversas investigaciones realizadas por los neurocientíficos, evidencian un consenso en la importancia de la primera infancia como un período sensitivo en el que se produce un significativo crecimiento y desarrollo cerebral que media en la formación de la personalidad, por la alta plasticidad que posee el cerebro la cual permite que las experiencias vividas lo modelen tanto estructural como funcionalmente.

En tal sentido, Caraballo, A. (2001) consideró que la primera infancia se reconoce, además, por la significación de la comunicación para lograr el máximo desarrollo integral posible en los seis primeros años de vida del niño. Este proceso constituye una herramienta cognitiva que permite la apropiación de la experiencia histórico-cultural y su transformación en experiencia individual mediante las interrelaciones sociales que se producen en la actividad.

Por tales razones, se considera que la comunicación tiene un lugar importante entre la familia y el niño desde la propia concepción, por lo que la misma debe realizarse en todos los momentos de la vida, comenzando desde la etapa intrauterina en la que debe prevalecer un clima emocional positivo estable. Por lo que la misma es un factor que puede fortalecer la relación entre los padres y el bebé, durante el embarazo.

Considerándose que el desarrollo debe ser guiado desde su génesis, el personal de educación está facultado para orientar, desde su rol de promotor, al personal de otros sectores. En esta labor brindan especial atención a los profesionales de la salud, quienes tienen dentro de su encargo social la orientación a las familias durante el período gestacional, por tanto, son los principales agentes educativos en esta etapa.

> La atención a la primera infancia y su consideración como un periodo esencial en el desarrollo del ser humano se reconoce desde hace más de

> 50 años pero ha sido en las últimas décadas cuando se ha hecho más evidente la importancia científica del periodo prenatal. (Andrés Viloria & Gutiez Cuevas, 2018, p. 26)

Por su parte al referirse al papel de las familias y su importancia en la educación Rodrigo Moriche (2018) apunta “cualquier familia, independientemente de su estructura, establece un modelo de crianza sustentado en las competencias parentales adquiridas de una manera implícita; sus cimientos se forman en la vida intrauterina” (p. 58).

Y enfatiza en la forma en que las familias logran desarrollar las competencias parentales cuando afirma:

> Una competencia parental adecuada desde el periodo prenatal y durante la fase de crianza se construye a partir de: las necesidades de los (futuros) niños y niñas, recursos y capacidades de las figuras parentales, las posibilidades de las personas implicadas en el proceso, y los recursos que la comunidad ofrece. La relación entre ellos se ajusta según las necesidades que se requieran en cada momento, adecuándose a las nuevas situaciones que se establecen. (Rodrigo Moriche, 2018, p. 58)

De este modo puede verse que la preparación de las familias parala educación de sus descendentes es un proceso complejo que dista mucho de ser espontáneo, de una forma u otra se es consciente del objetivo al que, como familia, se quiere alcanzar.

Refieren además, Sampayo, I., Moreno, V., Cuenca, M. (2013) que las familias son las encargadas de dicha misión en función de la estimulación de los niños, con énfasis en el desarrollo de la comunicación, algo que a su vez le permitirá el cumplimiento de sus funciones a partir de la intersectorialidad, como pilar básico de las modalidades educativas: institucional (círculo infantil y grado preescolar) y no institucional (Programa “Educa a tu Hijo”) en las que podrá desempeñarse.

Sin embargo, un período importante en la ontogénesis del desarrollo del lenguaje para dicho proceso lo constituye la etapa de gestación, aspecto esencial de esta investigación, período donde resulta significativo llevar a cabo el proceso de estimulación al feto al desarrollo óptimo de la comunicación en los bebés una vez nacidos, lo cual no siempre se realiza de una manera sistemática e integral por los factores que inciden en esta labor.

La familia es la institución social más antigua de la humanidad, donde todos se forman, es el lugar donde más protegido se siente el ser humano, para los niños es un ejemplo y un espacio ideal para el aprendizaje donde se debe promover la socialización y la creatividad y establecer patrones positivos de relaciones interpersonales donde juega un papel importante el correcto desarrollo del lenguaje. De ahí la necesidad de que la familia concientice el valor de la estimulación de la comunicación en la etapa prenatal y su significación para el desarrollo adecuado del futuro bebé. En tal sentido, la familia cubana ha experimentado modificaciones sensibles respecto a la educación de la infancia no sola en cuanto a la salud sino desde el punto de vista cognitivo y afectiva.

Varios autores han incursionado en la temática relacionada con el proceso de estimulación, a nivel nacional se destacan Huepp Ramos y Fornaris Méndez (2020) que abordan la estimulación temprana por parte de la familia a niños con factores de riesgo de retraso mental y Fernández Pérez de Alejo (2009) quien insiste en la necesidad de la educación desde las más tempranas edades.

Con relación a la categoría estimulación prenatal se entiende como un conjunto de actividades que constan de técnicas (auditivas, táctiles, visuales y motoras), que facilitarán la comunicación y el aprendizaje del niño por nacer. De esta forma, el niño será capaz de potencializar su desarrollo físico, sensorial y mental. Está basada en el desarrollo y maduración del sistema nervioso central y en particular del cerebro.

En tal sentido, hay que destacar que el trabajo de intersectorialidad demanda de la participación e implementación de acciones conjuntas entre los profesionales de la educación de la primera infancia unidos a otros sectores, lo cual tiene gran importancia para levar a cabo la estimulación prenatal. Sin embargo, solo se logrará si entre ellos existe un constante intercambio y retroalimentación, de manera que se atiendan no solo los logros ligados al desarrollo físico y psíquico, sino especialmente los relacionados con la comunicación, por el valor que cobra en la apropiación de la experiencia histórico - cultural, así como en el establecimiento de las interacciones sociales y de la regulación de su comportamiento.

En este sentido la interdisciplinariedad, como aspiración hacia la unidad del saber, ha estado presente en todas las etapas de la historia del hombre. En la actualidad, su estudio se ha acentuado en la misma medida que ha crecido el desarrollo de las relaciones entre las ciencias, incluyendo las humanísticas. Lo que antes constituía

un conjunto de elementos aislados, hoy se manifiesta como proceso continuo que afecta a la propia ciencia, a sus relaciones con la práctica y a la vida del ser humano.

Según Núñez, J. (2003) la interdisciplinariedad no es un objeto abstracto, sino el movimiento del conocimiento desatado por las necesidades de la actividad científica ligada a la práctica social. Tiene su génesis en la vida social, económica, política y cultural, uno de cuyos promotores cardinales es el adelanto de la ciencia y la tecnología.

Se constata el nivel ascendente de las investigaciones generadas por el tema de la interdisciplinariedad en todos los ámbitos: Alonso, H. (1994); Fiallo, J. (1997); Torres, J. (1998); Mañalich, R. (1998); Núñez, J. (1999); Álvarez, M. (1999);Salazar, D. (1999); Addine, F. (2000); Caballero, C. (2001); Aballe, V. (2001); Sol, Ma. Antonia (2003); Pérez, Y. (2005), Tamayo y Tamayo (2014) entre otros.

Como resultado de la experiencia personal en la atención comunitaria, entrevistas e intercambios con profesionales de salud, educación y deportes y observaciones de la consulta de estimulación temprana a embarazadas en el poblado de Siboney, se evidencian la necesidad de perfeccionar en la atención que se realiza a las mismas, en lo relacionado con la estimulación de la comunicación oral desde el período fetal.

Situación problémica:

- ✓ -En las visitas y consultas a las gestantes es insuficiente la orientación que se realiza para estimular al futuro bebé y la importancia que tiene para su desarrollo posterior.
- ✓ -En su mayoría, no emplean los folletos Educa a tu Hijo, en especial el dirigido a la embarazada, para orientar a las familias dicha estimulación.
- ✓ -No siempre emplean los métodos y principios de la orientación familiar en las consultas de puericultura y en las visitas al hogar para garantizar una adecuada estimulación mediante la comunicación, tanto verbal como no verbal.
- ✓ -Generalmente no existe un intercambio sistemático que permita la retroalimentación entre profesionales que intervienen en la primera infancia.

Esto trae como implicación que las familias no se apropien de los conocimientos necesarios para afrontar su función educativa desde los primeros momentos de la vida intrauterina ya que es de suma importancia para el desarrollo posterior del niño

y ayuda a crear mejores lazos familiares en función del nuevo miembro de la familia que está en formación y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se llega a el siguiente **Problema científico**: ¿Cómo contribuir a la preparación de las gestantes para la estimulación de la comunicación oral?

Abarcando como **Objeto de investigación:** El proceso de orientación familiar.

Se propone como Objetivo **de investigación:** Elaboración de un Manual de orientación familiar para la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal, en las gestantes del poblado Siboney.

En tanto se declara como c**ampo de investigación:** Orientación familiar para la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal.

Para darle cumplimiento al problema científico declarado se elaboran las siguientes **Tareas:**

1. Diagnosticar la situación actual del proceso de orientación familiar para la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal.
2. Determinar los fundamentos teóricos del manual interdisciplinario para la orientación familiar en la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal.
3. Elaborar un manual de orientación familiar interdisciplinario para la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal.
4. Valorar la factibilidad de manual interdisciplinario para la orientación familiar en la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal.

Para el desarrollo de las tareas propuestas se utilizaron métodos de investigación, tales como:

Métodos teóricos:

Análisis y síntesis: Para precisar los resultados obtenidos en la búsqueda de la información tanto teórica como empírica.

Inductivo-deductivo: se empleó para extraer regularidades, particularmente las referidas a los requerimientos teóricos y metodológicos, determinar generalizaciones y arribar a conclusiones.

Modelación: Para la elaboración del modelo teórico que sustente el manual de actividades de estimulación del lenguaje en la etapa gestacional.

Métodos empíricos:

Entrevistas a: entrevista a los profesionales de la salud que laboran en los consultorios médicos de la familia y promotores del programa educa a tu hijo.

Análisis de documentos: Para conocer las indicaciones del MINSAP para la aplicación de la estimulación del lenguaje en la etapa gestacional.

Criterio de expertos: Para conocer la valoración de expertos para valora a factibilidad del manual de actividades de estimulación del lenguaje en la etapa gestacional.

Entre los métodos estadísticos matemáticos se emplearon:

Análisis porcentual para procesar e interpretar los resultados desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo.

Importancia y actualidad del tema:

La estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal tiene gran importancia para el desarrollo intrauterino del niño, así como un mayor lazo familiar durante la etapa gestacional en la actualidad existen estudios que definen la estimulación del lenguaje en la etapa prenatal para el cual esta investigación realiza una propuesta de actividades para la ejecución oportuna de las técnicas de estimulación.

La estimulación intrauterina proporciona al futuro bebé importantes beneficios y experiencias necesarias para el aprendizaje como las siguientes: el cerebro aprovecha estas experiencias para formarse y cambiar constantemente, promoviendo y magnificando las interconexiones neuronales de su sistema nervioso; aumento del número de conexiones sinápticas; mejor desarrollo de los órganos de los sentidos del bebé dentro del útero; mayor desarrollo en el área visual, auditiva y lingüística.

La estimulación prenatal presenta beneficios en numerosas áreas esenciales para el futuro aprendizaje y desarrollo del niño/a, debido a que contribuye a lograr un mejor rendimiento motor, fomento del desarrollo en el lenguaje, la memoria, la inteligencia social y el razonamiento, así como beneficio en el desarrollo del vocabulario, la memoria, la coordinación vasomotora, el razonamiento y la inteligencia social, además de aumento de las habilidades para la música y la creatividad, procesando la información más rápidamente.

El impacto social que alcanza la investigación es evidenciar la necesidad que existe de implementar el servicio de estimulación prenatal como parte de los servicios de salud pública el INDER y los ejecutores de educación en el programa Educa a tu Hijo de forma integral y multi disciplinaria en el poblado Siboney.

Basados en los beneficios que aporta la estimulación prenatal al desarrollo intrauterino del bebé y a su capacidad adaptativa, mejorando la formación de las

estructuras corporales y cognitivas de los niños, en base a la proporción de ciertos estímulos para provocar su reacción. Y luego de evidenciar la falta de información y el bajo nivel de conocimiento que tienen las mujeres en estado de gestación acerca de las técnicas de estimulación.

Esta consideración resulta imprescindible si se toma en cuenta que la estimulación prenatal beneficia el desarrollo del bebé y esto posibilita que se adapte mejor al momento de nacer y tenga mejores posibilidades en el futuro para su desarrollo personal y social. El estudio de la estimulación prenatal por tanto genera un impacto social que permite a la población objeto de estudio analizar la importancia de realizar estimulación prenatal a sus hijos para obtener un mejor nivel de desarrollo cognitivo, físico y adaptativo.

DESARROLLO.

Epígrafe 1: Estado actual del proceso de orientación familiar para la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal

La investigación se desarrolló en el Poblado Siboney del municipio Santiago de Cuba. Se identificó como población a médicos y enfermeras de consultorio médico de la familia un total de 48 profesionales. Se escoge una muestra de manera intencional de 12 profesionales de la salud (para un 25 %) que laboren en consultorios médicos de familia que en su población presente 24 gestantes (que se selecciona como muestra, para un 100 %) con más de 16 semanas de gestación desde donde se proyecta la presente investigación. Se selecciona de una población de 8 promotores, los 8 como muestra (para un 100 %).

Para efectuar el diagnóstico de la situación actual, se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores:

- Características de la orientación familiar a las gestantes.
- Vías o métodos de preparación de las gestantes para la estimulación prenatal de la comunicación oral.
- Contenido y efectividad de la orientación que realizan los agentes para la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal

Para su desarrollo se aplican diversos métodos empíricos: la entrevista a los profesionales de la salud que laboran en los consultorios médicos de la familia del poblado (Anexo 1), entrevista a los promotores del programa Educa a tu hijo que laboran en el Poblado Siboney de 8 (para un 100 %) se entrevistaron a 8 promotores (para un 100%) (Anexo 2). Se realizó un análisis de los documentos de 12 Consultorios médico de la Familia de un total de 24 Consultorios Médicos de la Familia. (Anexo 3). Y una entrevista a gestantes: (Anexo 4).

Análisis de la entrevista a los profesionales de la salud que laboran en los consultorios (médicos y Enfermeras). (Anexo 1).

Se le realizo la entrevista a 12 profesionales de la salud de los cuales se arrojó que de 12 hay 10 licenciados, 6 especialistas en Medico General Integral y 4 master en Enfermería.

Los profesionales plantean que tienen 24 gestantes en su consultorio. Los 12 profesionales (100%) refieren que no le realizan ninguna técnica para estimulación de la comunicación en las gestantes.

Las 12 profesionales, (para un 100 %), refieren poseer conocimientos generales sobre el tema, que no han profundizado en la temática, por lo que no realizan la estimulación, su labor radica en el mantenimiento de la salud física de las gestantes y de su bebé

El 100 % de las entrevistadas no participan en ninguna preparación, que las capacite para realizar la estimulación de la comunicación en el periodo prenatal. Plantean que no realizan esta actividad porque dedican la consulta a mantener estable la salud de la madre y su bebé, refieren que este proceso tiene bastante exigencias que demanda una atención exhaustiva al respecto.

Platean el 100 %, que conocen los beneficios que brinda la estimulación prenatal, pero poseen insuficientes conocimientos de las técnicas para realizarlas.

Análisis de la entrevista a los promotores del programa Educa a tu hijo que laboran en el Poblado Siboney. (Ver Anexo 2).

Los 8 promotores de la muestra plantean que no conocen acerca de la estimulación prenatal de la comunicación oral (para un 100 %). Por lo que no aplican ninguna técnica para desarrollar la comunicación prenatal en las gestantes. Las entrevistadas abundan que no participan en ningún tipo de preparación o capacitación para desarrollar su actividad.

El 100 % refiere que no conoce a profundidad los beneficios que brindan las técnicas para la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal, Han escuchado sobre esta, pero no de forma científica.

Refieren que no poseen suficiente bibliografía sobre el tema, solo se prepara con los folletos de orientación familiar, pero que estos están dirigidos a realizar la orientación después del nacimiento del niño.

Análisis de documentos de Consultorio Médico de la Familia: (ver Anexo 3).

Se realizó una búsqueda en los documentos rectores de 12 Consultorios Medico de la Familia del Policlínico XX Aniversario Siboney donde se encontró con el Manual del Médico y Enfermera de la familia donde se constata que en él no está estipulada la estimulación prenatal como un elemento importante para la realización de esa actividad del médico y enfermera así como no existe el libro del Programa educa a tu Hijo que rige la estimulación temprana en el análisis de la estadística de del consultorio arrojo que de 24 embarazadas a ninguna se le indico estimulación prenatal.

Por lo antes expuesto se puede determinar el desconocimiento de los médicos y enfermeras del médico de familia acerca de la estimulación de la comunicación oral en la etapa gestacional ya que no existe una documentación que rija esta actividad en el consultorio.

Análisis de la entrevista a gestantes: (Anexo 4).

Se le realiza el instrumento a las embarazadas del policlínico XX Aniversario teniendo en cuenta de forma intencional que presenten de 14 a 20 semanas de gestación, que no presenten patologías asociadas ni factores de riesgo durante su embarazo se seleccionan a 24 que es un 100 % de la población de gestantes para la realización de la investigación con su consentimiento informado

De 24 gestantes se da a conocer mediante la investigación que un 83% han escuchado acerca del tema y un 17% desconoce de lo que se trata esta actividad. Las que han escuchado del tema no ha sido en consulta ni en capacitaciones del programa ni el INDER.

El 100 % plantea que nunca se han realizado ninguna técnica de estimulación prenatal. Por lo que no han recibido capacitación acerca del tema, y que le gustaría participar en la estimulación de la comunicación oral en sus bebés.

El 83 %, refieren conocer algunos beneficios de la estimulación prenatal, pero de forma no científica, sino del conocimiento popular

Las gestantes desconocen los beneficios y las técnicas que se realizan para la ejecución de la estimulación prenatal por estos motivos es importante la realización de un Manual Interdisciplinar para la estimulación de la comunicación oral en la etapa gestacional.

Después de aplicados y analizados los diferentes instrumentos se constataron las regularidades:

- Insuficiencias en la orientación familiar para la estimulación familiar en la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal, que se manifiesta en insuficientes acciones, actividades, estrategias para lograr el objetivo propuesto, por parte de los profesionales que atienden la etapa prenatal.
- Insuficiente desarrollo de una orientación interdisciplinaria, que permita la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal, que se manifiesta en la poca realización de actividades colegiadas entre todos los profesionales.

- Insuficientes conocimientos de las gestantes para la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal.

Estas regularidades nos permiten constatar la existencia de insuficiencias en el proceso de orientación familiar que imposibilita la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal. Por lo que es necesario el desarrollo de un Manual de orientación familiar interdisciplinario para la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal.

Epígrafe 2: Fundamentos teóricos del manual interdisciplinario para la orientación familiar en la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal.

2.1 Proceso de orientación familiar. Fundamentos teóricos.

La familia, su valor, su función y su misión dentro de las sociedades, es muy importante. En ella se da la renovación generacional que permite la preservación de la humanidad. Constituye la primera escuela y es donde se cultivan los valores, las aspiraciones de los miembros de la sociedad.

El papel de las familias como elemento vital en la estructura social e individual, que garantiza la adquisición de las primeras experiencias humanas, la formación, el desarrollo de la personalidad, el crecimiento como persona y la reproducción de los sujetos; resulta incuestionable en el logro de uno de los objetivos mediatos declarado por el Estado Cubano: la formación del hombre nuevo.

Para que la familia pueda cumplir con este rol tan importante dentro de la sociedad es necesario que posea una preparación cada vez mayor. El papel de la familia en la educación de sus hijos, requiere de un proceso de preparación que permita llevar a cabo esta importante misión.

En Cuba el estado le concede gran importancia a la familia como célula básica de la sociedad lo que aparece expresado en diversos documentos estatales y partidistas como la Constitución de la República, el Código de la Familia, el Código de la Niñez y la Juventud y las Tesis y Resoluciones del Partido.

Muchos son las investigaciones que se han referido al campo de la educación familiar, pero solo algunos de ellos toman en consideración las relaciones entre la familia y la escuela. Y entre estos se pueden señalar las siguientes:

Pedro Luis Castro Alegret (2005), la define:

> Sistema de influencias pedagógicamente dirigido, encaminado a elevar la preparación de los familiares adultos y estimular su participación consciente en la formación de su descendencia, en coordinación con la escuela. Esta educación suministra conocimientos, ayuda a argumentar opiniones, desarrolla actitudes y comunicaciones, estimula intereses y consolida motivaciones, contribuyendo a integrar en los padres una concepción humanista y científica de la familia y la educación de sus hijos. (p. 37)

Fusté, M., quien define la Orientación Familiar como:

> El proceso de comunicación donde se establecen determinadas relaciones hogar-escuela que posibilita diagnosticar la problemática de la familia y

> atenderla sobre bases objetivas y las particularidades concretas de ellas en un proceso continuo que tiene como fin su preparación para la realización eficiente de su labor educativa formativa. Es una finalidad que se alcanza de manera progresiva, por eso incluye una serie de actividades que tiene como objetivo evaluar a la familia, estimularla y dirigirla para que utilice los métodos efectivos en la formación y educación de sus hijos. (P 36)

La autora Martha Torres (2003) comparte la opinión de definir: "la orientación familiar como un "conjunto de acciones dirigidas a la capacitación de la familia para un desempeño más efectivo en el logro de sus funciones, de forma tal que garantice un crecimiento y desarrollo personal y como grupo" (p 32).

En esta investigación se asume la definición de Fusté, M., ya que en su concepto aborda la relación hogar-escuela y la importancia que tiene para lograr una comunicación con la familia, lo cual permite conocer sus particularidades y necesidades y así evaluarlas y diagnosticarlas, lo que a su vez posibilita dirigirla y prepararla con la finalidad de que estas seleccionen y empleen los métodos más efectivos en la formación y educación de sus hijos.

De lo anteriormente expuesto, podemos decir que la orientación familiar suministra conocimientos, ayuda a argumentar opiniones, desarrolla actitudes y convicciones, estimula interés y consolida motivaciones, contribuyendo a integrar en los padres una concepción humanista y científica de la familia y la educación de los hijos.

Los fundamentos psicológicos se basan en la escuela histórico cultural de L. S. Vigotsky, y de manera particular en los postulados teóricos siguientes:

-La ley genética del desarrollo que postula:

Las funciones psíquicas superiores existen en dos dimensiones diferentes: primero en el plano social interindividual o interpsicológico y posteriormente en el plano intraindividual o intrapsicológico. Ellas sufren cambios estructurales y funcionales en el proceso de transición de lo interpsicológico a lo intrapsicológico. Lo externo, que es cultural, llega a ser interno mediante un proceso de construcción con otros que implica la transformación de lo cultural y a su vez la transformación de las estructuras y funciones psicológicas. La utilización posterior de lo internalizado (producto cultural), ya transformado subjetivamente, se manifiesta en un proceso de externalización que conduce a la transformación de los procesos culturales. Esto indica una interacción dialéctica entre lo social y lo individual que no debe interpretarse como un acto de trasmisión cultural, unidireccional y mecánico, por

cuanto el sujeto es un ente activo, constructor y transformador de la realidad y de sí mismo, y no un simple receptor-reproductor.

- La zona de desarrollo próximo que postula:

La relación Educación-Desarrollo Psíquico se expresa de forma clara en los conceptos de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y Zona de Desarrollo Actual (ZDA) (Vygotsky, 1988). La Zona de Desarrollo Actual está conformada por todas las adquisiciones, logros y conocimientos que posee el niño, los que le permiten interactuar de modo independiente con lo que le rodea y resolver los problemas que se le presentan sin ayuda.

La Zona de Desarrollo Próximo está determinada por la distancia o diferencia entre lo que el niño es capaz de hacer por sí mismo y aquello que solo puede hacer con ayuda. Para lograr que la enseñanza provoque el desarrollo psíquico, que verdaderamente lo propicie, es imprescindible, considerar no sólo lo que ya ha sido aprendido por él, lo que ya conoce, domina y puede enfrentar y aplicar por sí mismo, sino aquello que aún no es capaz de enfrentar solo, pero que con una pequeña ayuda del adulto puede resolver. Esto expresa las potencialidades de desarrollo futuro del niño, sus posibilidades de aprendizaje, su enseñabilidad.

Para Vigotsky, esto posee un valor diagnóstico grande, pues de su análisis se puede conjeturar cuán amplia o estrecha es su Zona de Desarrollo Próximo; considerar la ZDP permite superar los diagnósticos y evaluaciones rígidos y estáticos del nivel de desarrollo de los sujetos (centrados en determinar los productos del desarrollo, el nivel de desarrollo real, la dimensión intrapsíquica descontextualizada.) al proponer una alternativa para evaluar sus potencialidades, sus posibilidades de desarrollo, justamente en la dinámica de sus procesos de cambio y transición evolutiva, debidamente contextualizados, lo que permite la aproximación al estudio de la naturaleza de dichos cambios.

La evaluación dinámica, como la llamó Vygotsky, se realiza en la situación interactiva, en la que se manifiestan las competencias de los sujetos para solucionar tareas con una menor o mayor ayuda de los adultos.

Los sujetos que requieren una menor ayuda poseen un potencial de desarrollo superior que aquellos que necesitan muchos apoyos. Se considera la cantidad y calidad de las ayudas para determinar la amplitud de la zona de desarrollo próximo.

El poder realizar un diagnóstico del nivel de desarrollo potencial del sujeto hace posible dirigir la estimulación de este potencial. En este sentido la escuela, como

institución socializadora, legítimamente responsabilizada con la trasmisión de los productos relevantes de la cultura, desempeña un rol fundamental.

Las ideas de Vigotsky acerca de los períodos sensitivos del desarrollo, como etapas de especial vulnerabilidad para la adquisición de determinados tipos de aprendizaje, han tenido un fuerte impacto en la educación, en el sentido de considerar las condiciones naturales y psicológicas idóneas para propiciar el desarrollo mediante un aprendizaje estimulador de las potencialidades que amplía la ZDP.

Los fundamentos filosóficos se sustentan en el materialismo dialéctico e histórico y por consiguiente en la teoría marxista-leninista del conocimiento, lo que permitió trazar pautas a seguir, desde la concepción del mundo que se asume, la objetividad, el papel práctico de la propuesta para lograr la preparación a la familia en la estimulación prenatal, hasta el análisis histórico concreto del fenómeno que se estudia, tanto en el plano teórico como en el práctico.

El enfoque dialéctico materialista subyace como base metodológica de los fundamentos teóricos sustentados en leyes y principios que rigen el desarrollo tanto en la naturaleza social y el pensamiento, el conocimiento de las leyes permite reflejar el mundo y su unidad e integridad.

Los fundamentos sociológicos también toman como sustento la sociología marxista que considera a la educación como fuente esencial inherente a la actividad social del hombre, y la influencia de la educación en la formación y transformación del hombre y la sociedad.

Los fundamentos pedagógicos se sustentan, además, en el pensamiento pedagógico cubano que sirve de base a las transformaciones que tienen lugar en el sistema educacional cubano y en la relación dialéctica que se establece entre las leyes, principios y categorías sobre los cuales se rige, pues estas explican su dinámica, concepción, aplicación y encargo social.

2.2 Fundamentos teórica de estimulación prenatal.

La estimulación intrauterina proporciona al futuro bebé importantes beneficios y experiencias necesarias para el aprendizaje: el cerebro aprovecha estas experiencias para formarse y cambiar constantemente, promoviendo y magnificando las interconexiones neuronales de su sistema nervioso; aumento del número de conexiones sinápticas; mejor desarrollo de los órganos de los sentidos del bebé dentro del útero; mayor desarrollo en el área visual, auditiva y lingüística.

También se relaciona con mejor rendimiento motor, fomento del desarrollo en el lenguaje, la memoria, la inteligencia social y el razonamiento, así como beneficio en el desarrollo del vocabulario, la memoria, la coordinación vasomotora, el razonamiento y la inteligencia social.

Al referirse a la estimulación prenatal Ramos, F., y Gualpa, C. (2011) abordan:

> es el proceso que promueve el aprendizaje en los bebés aún en el útero, optimizando su desarrollo mental y sensorial. Es un conjunto de actividades que realizadas durante la gestación enriquecen al niño por nacer en su desarrollo físico, emocional y social. (p. 24)

Se puede analizar de las definiciones anteriores que la estimulación prenatal son una serie de actividades que se pueden realizar para estimular reacciones en el feto, a fin de mejorar las habilidades sensoriales y de respuesta del niño y que tenga una mejor adaptabilidad al medio ambiente en el momento del nacimiento y posteriormente.

Hernández (2016) plantea que “la estimulación prenatal se entiende como un conjunto de actividades que constan de técnicas (auditivas, táctiles, visuales y motoras), que facilitarán la comunicación y el aprendizaje del niño por nacer”(p 362). De este modo la autora considera implícitamente que la estimulación prenatal como actividad posee objetivos, acciones a desarrollar y operaciones para llevarla a cabo.

Según Paricio Andrés (2019) “la estimulación prenatal se puede definir como el conjunto de acciones que proporcionarán al niño las experiencias que éste necesita para potenciar las capacidades y habilidades infantiles, desde la fecundación, para desarrollar al máximo su potencial bio-psico-social” (p.1).

Se considera que esta definición dispone los criterios necesarios e importantes que componen el proceso de estimulación prenatal. De tal manera, se asume esta definición por considerar la más acabada y completa acerca de la comunicación intrauterina y particulariza aspectos que coinciden con la investigación que se está realizando.

Anleu, G. (2013) señala que la estimulación en útero “son técnicas físicas y de relajación aplicada por los padres durante la gestación, con el objetivo de favorecer el desarrollo del niño o niña por nacer” (P 15).

En esta definición se aportan que la estimulación del útero a través de técnicas que percibe el feto durante el periodo de gestación.

Los diferentes programas diseñados tienen como finalidad dar al futuro bebé, excelentes condiciones que le permitan desarrollarse mejor según su proceso natural, su propia dinámica y desarrollar todas las capacidades y facultades que posee en su carga genética, que va a depender del amor y compromiso tanto de la madre como el padre con su bebé.

Varios autores han abordado el tiempo idóneo para comenzar la estimulación prenatal. Al respecto:

Oates, J. et al (2012) mencionan que

> cuatro semanas después de la gestación, antes incluso de que una madre sepa que está embarazada, el cerebro del feto ya se está empezando a formar.
>
> > El sistema nervioso es uno de los primeros sistemas en formarse pues debe controlar las funciones del embrión y del feto como la alimentación celular para el crecimiento y supervivencia del mismo. (p. 22)

El cerebro del niño comienza a desarrollarse apenas pocos días después de la concepción. Una inmensa porción del crecimiento cerebral tiene lugar antes del nacimiento del niño, primero mediante la abundante creación de neuronas y luego mediante las numerosas conexiones axónicas que se forman entre ellas. Antes de nacer y durante el primer año de vida se constituyen los sistemas y caminos cerebrales, a medida que van sobreviviendo las neuronas frecuentemente activas y van muriendo las neuronas activadas con menor frecuencia

Durante la etapa prenatal el desarrollo cerebral es asombroso de tal modo que al nacer el niño ya cuenta con todas las células cerebrales luego del nacimiento no se crean más células cerebrales.

Oates, et al. (2012) señala que: al terminar el tercer mes de gestación, el sistema nervioso está lo suficientemente desarrollado como para que se manifiesten reflejos físicos básicos, junto con reacciones tales como dar patadas o doblar los brazos.

Al inicio del segundo trimestre del embarazo el cerebro ya inicia el control de las habilidades motrices por medio del sistema óseo y muscular y empieza a generar movimientos básicos que luego del nacimiento iniciarán su proceso de maduración para ejecutar los movimientos voluntarios con acción dirigida e intencional.

Progresivamente a la producción de células nerviosas el cerebro adquiere la responsabilidad de todas las funciones del cuerpo humano, comienza a recibir los

impulsos sensoriales que recibe del medio ambiente por medio de los órganos de los sentidos los estímulos del medio ambiente llegan hasta la corteza cerebral son interpretadas y se elaboran respuestas.

Señala que durante las etapas finales embarazo, el número de neuronas comienza a disminuir ya que la muerte celular elimina a aquellas que no están activamente involucradas en el desarrollo de las vías y los sistemas cerebrales.

Por este motivo resulta necesario proveer al cerebro del niño de estímulos diversos incluso antes de su nacimiento puesto que aquellas células que no se encuentran activas empiezan a morir por considerarse innecesarias, mientras mayores son los estímulos que se provea al niño en el vientre materno mayor será su desarrollo y menor el número de células nerviosas que mueran.

Las bases teóricas sobre las que se fundamenta la estimulación prenatal son la evidencia recolectada de varios estudios y análisis que dejan ver las relaciones que se establecen por medio de la estimulación entre el feto y las personas que lo rodean.

Le Boulch (2000) hace referencia al desarrollo cerebral intrauterino como base teórica para la estimulación prenatal mencionando que: Tras los primeros diecisiete días de concepción, el feto empieza a desarrollar las primeras conexiones sinápticas, que determinarán la estructura de su cerebro, asimismo, se ha comprobado que la estimulación prenatal favorece el incremento de estas conexiones sinápticas.

Durante el octavo mes del embarazo, el bebé dispondrá de entre dos y tres veces más células nerviosas de las que cualquier adulto pueda tener. Antes del nacimiento iniciará también el proceso natural de muerte natural por lo que es necesario aprovechar este periodo para la estimulación prenatal.

Varios estudios demuestran que los bebés escuchan la voz de su madre desde la vida uterina, incluso se ha manifestado que los pequeños pueden recordar melodías escuchadas antes de nacer. En efecto existe en los bebes la capacidad de reaccionar ante su entorno por medio de los sentidos, por esto él bebe es consciente de lo que su madre piensa y siente, sin embargo, no se tenía claro si estos sonidos formaban parte de un aprendizaje propiamente dicho.

Se pensaba que el cerebro del bebé era inmaduro, incapaz de pensar y que no era probable ningún proceso de aprendizaje que no fuese una respuesta refleja, pero en la actualidad varias investigaciones referentes con la estimulación prenatal

afirman que el bebé, antes de nacer, es idóneo de obtener y procesar información de diversos estímulos y que requiere una relación entre el desarrollo del cerebro y los órganos de los sentidos del bebé dentro del útero.

Todos estos nuevos conocimientos, revelados gracias a la experimentación y que confirman algunos de los sentimientos de las madres, adquieren nuevas actitudes con respecto a la gestación y al nacimiento. Con lo cual se obtiene grandes beneficios que en los bebés que son estimulados tienen la capacidad de un mejor aprendizaje y coeficiente intelectual, para cada ser humano son importantes sus sentidos antes del nacimiento porque por medio de ellos puede escuchar, sentir y puede percibir las emociones de la mamá.

Se ha podido detectar que las sinapsis se dan a partir del décimo séptimo día de la fecundación hasta el quinto mes del embarazo, es aquí donde la cantidad total y definitiva de neuronas del cerebro está determinada y empieza el proceso de mielinización, la cual es importante porque facilita la transmisión nerviosa. En consecuencia, la capacidad mental del feto habrá aumentado tanto como se halla estimulado tempranamente.

Además, se ha comprobado que, la estimulación prenatal favorece el incremento de estas conexiones sinápticas, es decir que, si no existen estímulos, no se establece la misma cantidad de conexiones, y la célula acaba aislada y termina por morir.

El objetivo de la estimulación prenatal es crear el mayor número de conexiones posibles, disminuyendo con ello la muerte celular. Cuántas más neuronas y conexiones tengan un bebé al nacer, mayor será su futuro potencial de desarrollo.

El ser que se está formando, desde el período embrionario recibe las vibraciones sonoras a través de las células receptoras de su piel, de sus músculos, de sus articulaciones, pero cuando el oído empieza a funcionar, filtra los sonidos graves y sólo percibe los agudos. Este sistema de protección contra los ruidos internos del organismo de la madre que no se para ni de día ni de noche es indispensable. Pues sino el bebé no podría reposar nunca. Así mismo los centros del lenguaje se preparan desde la vida uterina, activados por la estrecha comunicación madre - bebé.

Los patrones del habla son tan definidos como las huellas digitales y el origen de ellos y su aprendizaje comienza antes del nacimiento. Existe una impregnación de frecuencias agudas en el feto (debido a leyes mecánicas, en los cuerpos duros las

frecuencias elevadas pasan mejor que las graves que vibran menos) y hay una reactividad que se establece alrededor de los 2.500 Hz, pero con unos armónicos específicos para cada mujer.

El feto oye claramente desde el quinto mes y adapta su ritmo corporal al habla de su madre. Los bebés reaccionan a la luz a partir de las 28 semanas de gestación, aunque tenga los párpados fusionados. (Ejemplo en prueba de amniocentesis).

Se sabe que los mecanismos químicos del gusto están formados a partir de las 14 semanas. Si se encuentra sustancias dulces las traga fácilmente y rápidamente, y hace muecas si detecta un sabor amargo en el líquido amniótico. El bebé come y bebe lo que su madre come y bebe. Si la madre o el padre fuman, el bebé sufre los efectos tóxicos. Y los medicamentos tomados en dosis para adultos, le llegan al bebé en dosis de adultos.

La sensibilidad táctil del bebé empieza a la séptima semana de gestación. Este tacto permite tanto al padre como a la madre establecer una relación con el bebé a través del abdomen de la madre. Es un tacto con intención afectiva y esto el bebé lo percibe. Si un bebé está mal colocado a la hora de nacer, con movimientos sutiles y ligeros hace que el bebé encuentre la posición buena para nacer.

Entre la semana 10 a la 12 se desarrolla el tacto, inicialmente en la zona de los genitales, seguidamente se da en las manos y finalmente en la planta de los pies. A finales del cuarto mes, el feto desarrolla la audición, pudiendo distinguir sonidos fuertes, los cuales llegan a alterarlo.

Hacia las 14 semanas el bebé, ya escucha. El bebé, recibe la voz de su madre a 24 decibeles, aunque la emisión de la madre se haga a 60 db, mientras que otras voces femeninas sólo las escucha a 12 db, esto hace que el bebé reconozca bien la voz de su madre. Uno de los investigadores pioneros sobre la audición es Tomatis, citado por Terre (2005). Plantea que el bebé, escucha los sonidos antes de que el oído esté formado. El sonido le llega al bebé, a través de la columna vertebral de su madre, que constituye un puente vibrante entre la laringe y la pelvis. La voz de su padre le llega al bebé, a través del tímpano de la madre, sigue el sistema óseo y el bebé la recibe como una modulación, recibe la cadencia y el ritmo.

A inicios del quinto mes de embarazo, se da lugar el desarrollo del gusto y el olfato. Puede mover sus brazos y piernas con fuerza, sus dedos son más hábiles, su habilidad para percibir a través de la piel se acrecienta, desarrolla coordinación y fuerza.

A los seis meses los órganos y centros se especializan. El feto percibe las informaciones a través de todos sus sentidos; es capaz de reaccionar ante ellas y las memoriza. Se chupa el pulgar, juega con el cordón umbilical, acaricia su cuerpo, sus movimientos son más rápidos; aparece el hipo, la madre siente al bebé intrauterino como suaves empujoncitos en la pared abdominal. Escucha y aprende, identifica estímulos y responde a ellos. En el séptimo mes, el sentido de la vista también se ha desarrollado, dentro de poco abrirá los ojos por primera vez. Reacciona a los cambios de luz y puede seguir una fuente luminosa.

Durante el octavo mes, el sistema nervioso está formado y listo para operar. A su vez en esta etapa, aumentan los movimientos faciales, protrusión de la lengua y diferentes gestos con la boca. La complejidad de los patrones de movimientos faciales se considera propia de un correcto desarrollo neurológico. En el noveno mes continuará creciendo y desarrollándose, al mismo tiempo que suceden transformaciones fisiológicas que lo prepararán para salir al mundo exterior.

Los bebés en el útero son seres sociables y comunicativos, que sienten el amor o el rechazo de su madre, que sienten placer y dolor, que el estrés de sus madres les repercute, en el plano emocional y en el físico, interfiriendo en la formación de sus órganos. En el período prenatal, la impregnación celular es máxima. El niño en el útero se impregna de todo lo que vive su madre.

Terré, O. (2005), cita numerosas investigaciones en relación a la estimulación prenatal donde se explica que el desarrollo de los sentidos del bebé evidencia la capacidad para obtener información de su entorno, intrauterino y de permitirle, a través de su sistema nervioso y muscular, aprender y responder a variados estímulos.

En varios de estos estudios se demuestra que el bebé en el período intrauterino por pequeño o frágil que parezca, siente y se da cuenta de todo lo que ocurre a su alrededor: percibe los estados anímicos de la madre, oye cuando le hablan y aunque sea en forma rudimentaria comienza a reconocer las voces y sonidos más familiares.

Por esta razón, resulta fundamental comenzar a educar al futuro hijo desde el embarazo. También es importante la necesidad de preferir aquellos estímulos que se dan en forma natural, antes que los producidos artificialmente, con el fin único de provocar reacciones en el bebé, pues el exceso de actividades podría sobre estimularlo antes de su nacimiento.

Las bases neurológicas de la estimulación prenatal se centran en el desarrollo y maduración del Sistema Nervioso Central, (SNC) y en particular del cerebro. El SNC está formado por el cerebro, situado en la parte anterior, y la médula espinal, más pequeña y de forma cilíndrica. El cerebro se divide en cinco regiones: telencéfalo el cual está formado por los hemisferios cerebrales, el diencéfalo compuesto por el epitálamo, tálamo, hipotálamo y subtálamo; el mesencéfalo que comprende pedúnculos cerebrales y el techo; el metencéfalo que incluye la protuberancia anular y el cerebelo, y por último el mielencéfalo (bulbo raquídeo).

A menudo, el bulbo raquídeo, mesencéfalo y la protuberancia anular se conocen en conjunto como tallo encefálico. La luz del SNC es una hendidura estrecha en la médula espinal, que se expande en un sistema de ventrículos el cual está lleno de líquido raquídeo. Doce pares craneales emergen del cerebro para establecer la inervación motora, sensitiva y parasimpática de la cabeza y el cuello, así como gran parte de las vísceras.

El cerebro humano está formado por células (neuronas); las cuales son unidades funcionales del SNC, siendo capaces de recibir, conducir y transmitir impulsos entre sí, a las células musculares y glandulares. La neurona consta de tres partes, la primera es el soma o cuerpo celular nervioso, y su citoplasma se conoce como pericarion conteniendo otros organelos de la neurona; la segunda parte son las dendritas, típicos procesos ramificados cortos que reciben señales de otras neuronas.

Las dendritas se extienden en diferentes direcciones y de esta manera incrementan la capacidad de una neurona para recibir impulsos de diversos orígenes; la tercera parte es el axón, el cual puede variar mucho en longitud y se caracteriza por conducir impulsos que se alejan del cuerpo celular. Estas neuronas para el desarrollo cerebral, deben constituir sinapsis, el cual significa conjunción o conexión entre dos neuronas.

Un impulso nervioso se puede propagar en cualquier dirección a largo de la superficie de un axón. La sinapsis entre neuronas es por las ramificaciones llamadas dendritas, por donde reciben impulsos nerviosos de otras neuronas, estos impulsos nerviosos viajan a través de una prolongación más larga llamada axón, que a su vez se contacta con otras neuronas, formando circuitos neuronales. Las neuronas intercambian a través de la sinapsis, unas moléculas químicas llamadas neurotransmisores, que se convierten en un impulso eléctrico.

La estimulación prenatal se fundamenta en el desarrollo y maduración del sistema nervioso central y, de forma particular, del cerebro. Las neurociencias se ocupan del sistema nervioso, de sus aspectos y funciones especializadas e involucra tanto a la biología del sistema nervioso como a las ciencias humanas, sociales y exactas que representan la posibilidad de contribuir al bienestar humano, por medio de mejoras en la calidad de vida durante todo el ciclo vital.

Según Villacorta, E. (2004), la estimulación prenatal aporta muchas ventajas al bebé:

- Mejora la interacción de los padres con el bebé que se encuentra en formación.
- Optimiza un máximo desarrollo de los sentidos base para su aprendizaje.
- Asegura un buen estado de la salud física y mental del bebé que está por nacer.
- Permite el desarrollo de un vínculo afectivo bebé-padres-familia.
- Desarrolla pre aprendizajes para la comunicación, lenguaje, vocabulario, coordinación visomotora, memoria, para iniciar y continuar con éxito la educación.

Así mismo Vargas, R. (2010), en Venezuela, demostró que los niños con estimulación prenatal son menos llorones, mucho más activos, tienen mejor capacidad de adaptación en el medio externo y al momento de generar este vínculo que tiene la madre al realizar los estímulos prenatales, logra tener confianza durante la gestación y sentirse bien ella y el bebé.

Aguaiza, T. (2012), realizaron un trabajo de grado que hablas sobre estimulación prenatal en mujeres adolescentes, su investigación nos habla que la estimulación prenatal es muy importante ya que desde un principio los padres deben promover un ambiente seguro y amoroso para motivar el aprendizaje de bebé antes del nacimiento. Como resultado de esta investigación se creó el Subcentro de Salud Sur de la ciudad de Tulcán, Perú.

Vallejo, L. realizó una investigación en el año 2013 sobre estimulación prenatal y demostró que, la mayoría de mujeres en período de gestación no estimulan a sus bebés desde el vientre materno y que existen factores que permiten que las madres no concienticen la importancia de la estimulación prenatal y estos son: factor cultural, factor social y factor académico.

En Europa sobresalen los estudios, González, H. (2014), en España que propone varias técnicas relacionadas con la terapia de los colores y las fragancias, así como la influencia de las vivencias emocionales de la madre durante la gestación, sobre el temperamento y la salud de su bebé. Las estadísticas le revelaron que hay una correspondencia evidente entre las perturbaciones emocionales de la madre y los problemas de salud y problemas psicológicos del niño.

Estudios realizados en Cuba, en Villa Clara, por: Escobar, Ariz y Cepero (2008), avalan los efectos positivos de la estimulación prenatal temprana en el recién nacido y sus respectivas familias. En La Habana Moreno, Pérez, Hernández y Álvarez (2011), obtuvieron excelentes resultados en un proyecto de estimulación del neurodesarrollo, demostrando las posibilidades de estos programas.

En la provincia de Cienfuegos se destacan los estudios realizados por Moya, O. Santos, D., Franco, M. E., Ruíz, A. y Pérez, G. (2003), estas investigaciones exponen algunos factores influyentes en el desarrollo de la comunicación madre-bebé, así como propuestas de orientación a gestantes.

Todas estas investigaciones demuestran que el período intrauterino es sumamente sensitivo y potencialmente estimulador del neurodesarrollo. Por lo que se puede asumir un posicionamiento favorable con respecto a la estimulación prenatal, así como la necesidad de profundizar en la naturaleza, variabilidad y disponibilidad de estímulos que recibe el bebé en el período intrauterino.

¿Cuáles serían los canales para establecer la estimulación prenatal?

Existen tres canales de comunicación:

- Canal de comunicación biológica – molecular.
- Canal de comunicación de comportamientos y conductas.
- Canal de comunicación emocional e intuitiva.

El canal de comunicación biológico – molecular está relacionado con todo el pasaje de diferentes nutrientes durante la gestación, es el que garantiza su vida biológica y estimula su crecimiento y desarrollo. Las moléculas maternas de las emociones, incluidas hormonas del estrés como la adrenalina y la noradrenalina, las neuro-hormonas y las hormonas sexuales, llegan al futuro bebé a través del cordón umbilical y la placenta. En este sentido el bebé forma parte del cuerpo de su mama tanto como el corazón o el hígado.

El canal de comunicación de comportamientos y conductas es la línea de comunicación a través del contacto y la audición. Tiene que ver con las caricias de

la madre a la panza tanto desde del exterior como de su interior a través del líquido amniótico. Los movimientos del cuerpo de la madre, tanto en actividad como en reposo a través de su respiración y relajación. Las respuestas del bebé a las conductas y comportamientos antes detallados por parte de la madre. Tales respuestas se manifiestan a través de pataditas o movimientos que realiza el bebé. En el caso de la audición tiene que ver con ritmos y ruidos propios de la madre. Madres que escuchan música y le hacen escuchar desde la panza, la música. Las respuestas del bebé al aumentar su movimiento o calmarse cuando escucha a su madre o aquella música que le resulta placentera.

El canal de comunicación emocional-intuitivo es una ruta difícil de comprobar, porque corresponde al área de la transmisión de emociones. Todo el flujo bioquímico y hormonal desencadenado a partir de ellas bañará el hipotálamo (sector de nuestro sistema nervioso responsable de ser el regulador emocional del organismo), la corteza cerebral y el sistema endocrino del bebé, que reaccionaran a predisponer su conducta y sus respuestas.

El amor es un buen ejemplo cuando la madre acaricia dulcemente su barriga, cuando come y bebé con sensibilidad transmite afecto al hablarle y siente que lo quiere cada vez que lo imagina o piensa en él. Cuando sucede esto, hormonas y transmisores neuro hormonales serán liberados en su circulación y serán luego trasmitidos a la circulación del feto a través de su línea privada de comunicación: la placenta. Allí se comunicarán mucho más que simplemente sus circulaciones, se comunicarán sus emociones.

Estudios realizados por investigadores han demostrado que aquellas madres que estimularon a sus bebés se mostraron más seguras y activas durante el nacimiento y experimentaron un mayor éxito durante la lactancia materna. Los bebés estimulados y sus familias revelaron lazos más intensos y una mayor cohesión familiar. Cada experiencia que logre vivir el niño(a) desde el vientre de su madre lo va a marcar, el bebé no será un objeto, sino un sujeto que se va a ir desarrollando a partir de la estimulación recibida.

Las condiciones psicológicas en las que se desarrolla el embarazo tienen un papel determinante en el desarrollo del individuo en gestación. La angustia o ansiedad persistente vivida por la madre puede afectar el desarrollo emocional del niño.

Cuando se sufre de estrés el organismo humano activa diferentes procesos hormonales en respuesta, glándulas suprarrenales en particular, fabrican la

adrenalina, las catecolaminas, las llamadas hormonas del estrés, que permiten hacer frente a esa situación. En la mujer embarazada, estas hormonas atraviesan la barrera placentaria, inundan el feto, creando en él un estado fisiológico correspondiente a esta emoción materna.

De igual manera cuando prevalece un estado de alegría, de felicidad, de bienestar, el cerebro segrega las endorfinas, llamadas las hormonas de la felicidad que, en una mujer en gestación, van a comunicar al hijo la tranquilidad, estabilidad, sosiego, alegría de vivir.

Se ha demostrado que si prevalecen estos estados hay muchas posibilidades de influir en el carácter del hombre o de la mujer que va a venir, que tendrán el gusto por la vida, una aptitud innata para la felicidad, y crearán de forma natural en su personalidad las condiciones capaces de realizarla. El oído, como primer órgano sensorial que se activa, ya desde los primeros días de su vida el niño va captando informaciones.

El embrión-feto no solo recibe pasivamente los sonidos, sino que graba mensajes, percibe situaciones, interactúa con su madre y acumula toda la historia afectiva del embarazo. El oído, gracias a una de sus partes (el vestíbulo o laberinto membranoso) reconoce los ritmos desde las primeras semanas de vida intrauterina. La puesta en marcha del vestíbulo marca el inicio de la motricidad y de la sensibilidad del pequeño embrión. El vestíbulo es el punto central de la estructura primitiva del SNC y actúa como centro de control, adaptando y corrigiendo la información muscular, tanto de entrada como de salida, a nivel sensorial y motor entre las 7ª y 8ª semana, el laberinto membranoso está terminado en cuanto a la diferenciación de los órganos principales que los constituyen: el utrículo, el sáculo, los canales semicirculares y la cóclea.

Los sonidos que oye el bebé en el útero son de varios tipos: Los que provienen del cuerpo de la madre, que constituyen una especie de ruido de fondo: como los ruidos digestivos y los latidos del corazón, los que le llegan del exterior como voces, música, que le llegan como filtrados. Así como ruidos demasiado intensos pueden llegar a perturbarle, incluso se han llevado a cabo experimentos que demuestran que una exposición prolongada a ruidos demasiado intensos, en determinados momentos críticos de la formación de la función auditiva, puede provocar déficits auditivos notables, e incluso un sufrimiento cardíaco severo.

Tipos de estimulación prenatal

- Técnica Táctil:

Se realiza a partir de la sexta a décima semana de gestación, mediante la utilización de diversos instrumentos (masajeadores, texturas), aplicados a nivel del dorso fetal, a través del vientre materno. Su aplicación a diferentes presiones genera vibraciones que se transmiten a través del líquido amniótico y son captados por los nervios periféricos de la piel del bebé. Este estímulo es transmitido a la médula espinal y luego al cerebro, produciendo así cambios físicos como es el movimiento del bebé

- Técnica Auditiva:

La audición es uno de los sentidos que conecta al bebé con el mundo exterior y a su vez es uno de los que más se pueden estimular, ya que el aparto auditivo del bebé se desarrolla aproximadamente a las 14 semanas de gestación, siendo entonces cuando empieza a captar los sonidos externos e internos. El sonido opera como un neurotransmisor interactivo actuando directamente sobre el sistema neurovegetativo celular e hipófisiario del feto, dejando impreso un registro a modo de huella. Por ejemplo, las sensaciones producidas por la música van a quedar grabadas en el futuro bebé, que lo remitirá una vez nacido a ese estado placentero que vivió durante su gestación.

- Técnica Motora:

Se realiza a partir de las 10 semanas de gestación; ya que por esos momentos se forman los canales semicirculares relacionados con el equilibrio. La estimulación se realiza por las diferentes posiciones que toma la madre durante el embarazo en su vida normal o a través de los ejercicios físicos apoyados por una respiración adecuada. El feto dentro del útero se informa de su posición decepcionando si la madre se encuentra de pie o en una posición que afecte su equilibrio intraútero, logrando así desarrollar el centro del equilibrio del niño poniéndolo en alerta”

- La Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo Conductual (AEPCCC) (s.f.), agrega la Técnica de Relajación.

Esta ayuda a realizar un trabajo consciente, con los músculos y órganos que tendrán actividad directa en el desarrollo del parto y se estimulen las glándulas endocrinas. Las actividades incluidas en esta etapa son la gimnasia psicofísica prenatal, el trabajo de estiramiento y respiración, los ejercicios de relajación, el trabajo de posturas, la meditación y la concentración. Estas actividades proporcionan un beneficio para la salud, equilibrio emocional y relajación de la

madre, brindando un ambiente placentero al feto y preparación para el momento del parto.

Beneficios de la estimulación prenatal

El artículo estimulación prenatal de la Universidad de Valencia (s.f.), cita al Dr. Villacorta, E., médico pediatra del colegio médico del Perú y la investigadora Lilian López, quien se rige con las pautas de la Organización Mundial de Asociaciones de Educación Prenatal (OMAEP).

El Dr. Villacorta, E. afirma que la estimulación prenatal aporta muchas ventajas al bebé, entre las que destaca: Mejora la interacción de los padres con él bebe en formación, optimiza el desarrollo de los sentidos base para su aprendizaje, asegura la salud física y mental del niño por nacer, desarrolla el vínculo afectivo niño-padres-familia, desarrolla la comunicación, lenguaje, vocabulario, coordinación visomotora, memoria, razonamiento e inteligencia social, funciones básicas para iniciar y continuar con éxito la educación formal.

Según Liliana López (s.f.), cada uno de los estudios comprueba que el bebé por pequeño y frágil que parezca, siente y se da cuenta de todo lo que ocurre a su alrededor: percibe los estados anímicos de la madre, oye cuando le hablan y aunque sea en forma rudimentaria comienza a reconocer las voces y sonidos más familiares. Por este motivo, resulta fundamental comenzar a «educar» al futuro hijo desde el embarazo.

Según los estudios realizados por Tomas R. Verny y Rene van De Carr (s.f.), han mostrado que los bebes que han sido estimulados en el útero, demuestran que al nacer tienen un mayor desarrollo visual, auditivo, lingüístico y motor, así como salud física, se muestran más alertas y seguro en relación con los no estimulados y tienen mayor facilidad de aprendizaje.

Todo lo anterior se logra si son estimulados desde el vientre, pues es sabido que, a los diecisiete días de concepción, el feto empieza a desarrollar las primeras conexiones sinápticas (conexiones entre las neuronas), que determinarán la estructura de su cerebro, y dicha estimulación favorece el que se lleve a cabo dichas conexiones.

Aporte de la psicológico.

El embarazo está influido no solo por factores biológicos sino psicológicos y culturales y han de ser tenidos en cuenta por su influencia en la madre-padre-feto. Si no es así, el embarazo será vivido por la mujer como un estado biológico en el

que esta se somete a la autoridad del personal sanitario. Tener en cuenta estos aspectos nos brinda la posibilidad de prevenir dificultades durante el embarazo y también tras el nacimiento.

Durante el embarazo, los cambios que la mujer experimenta no sólo son funcionales para la formación del embrión y el feto sino también emocionales para la progresiva incorporación cognitiva y emocional del futuro niño en la familia. Curiosamente, durante el embarazo se producen cambios cerebrales en las madres que afectan a áreas específicas, como son el hipocampo o el bulbo olfatorio, asociadas con funciones necesarias para gestionar los retos de la maternidad.

Se afirma que madre e hijo comparten sistemas neuro hormonales, siendo los componentes afectivos desencadenantes de secreciones hormonales que modifican el medio biológico en el que se desarrolla el futuro niño. El estrés materno puede condicionar el desarrollo emocional y conductual del niño y es uno de los factores de riesgo de la prematuridad, o del bajo peso al nacer, de la irritabilidad futura del niño y de otras alteraciones.

Lafuente (2010) afirma que el bienestar emocional de la mujer embarazada es un factor de su salud tan importante como los físicos y los estilos de vida ya que el aumento del estrés puede afectar al embrión y al feto, como se ha señalado. Así mismo, existen factores que pueden suponer una dificultad para la vinculación materna como puede ser el estrés, el embarazo no deseado, la edad de la madre, el apoyo social, su personalidad, la relación de pareja, su estado anímico, etc., que pueden repercutir en el posterior desarrollo. Es importante facilitar a la madre un ambiente sosegado y los apoyos necesarios para afrontar demandas y tensiones excesivas

Por ello, sostener a la futura madre será el papel no solo del padre y la familia sino también del acompañamiento y apoyo social que pueda tener, así como del programa de educación prenatal. La especificidad del desarrollo fetal implica pensar también en el contexto interpersonal. La vinculación afectiva comienza en la etapa prenatal y existen comportamientos que ponen de manifiesto su existencia; esta se ve reforzada por las capacidades que el niño por nacer va desarrollando y que la madre interpreta confiriéndoles sentido relacional. El padre y la madre establecen con él comportamientos comunicativos y se crean fantasías sobre el futuro bebé atribuyéndole significado como sujeto individual.

El vínculo afectivo también genera los siguientes beneficios para la gestación:

- ❖ Favorece una adecuada relación de entendimiento padre-madre-hijo ya que el vínculo afectivo aumenta la sensibilidad hacia el entendimiento del otro.
- ❖ Ayuda a la madre a soportar de manera positiva los problemas que pudieran surgir durante la gestación generando confianza en sí misma para el proceso.
- ❖ Se reducen los miedos e inquietudes de la pareja durante el proceso, propiciándose una actitud realista de la maternidad y la paternidad, favoreciendo el aceptar al recién nacido tal como es.
- ❖ Induce a la mujer durante el embarazo a desarrollar conductas de promoción de la salud física y psíquica tanto de ella como del niño, reduciendo el número de complicaciones físicas, emocionales y psicosociales.

2.3. La interdisciplinariedad.

En estos momentos, la práctica pedagógica demanda la implementación de la interdisciplinariedad en el proceso de mejora de los procesos que se realizan, con el fin de obtener mejores resultados. En este sentido la interdisciplinariedad, como aspiración hacia la unidad del saber, ha estado presente en todas las etapas de la historia del hombre. En la actualidad, su estudio se ha acentuado en la misma medida que ha crecido el desarrollo de las relaciones entre las ciencias, incluyendo las sociales. Lo que antes constituía un conjunto de elementos aislados, hoy se manifiesta como proceso continuo que afecta a la propia ciencia, a sus relaciones con la práctica y a la vida del ser humano.

Mayor, F. (1997), aborda que: “La interdisciplinariedad esencialmente, consiste en un trabajo colectivo teniendo presente la interacción de las disciplinas, de sus conceptos directrices, de su metodología, de sus procedimientos, de sus datos y de la organización en la enseñanza” (p. 39).

Fiallo R., J. (2016), al referirse a la interdisciplinariedad apunta: “Es un proceso y una filosofía de trabajo, es una forma de pensar y de proceder para conocer la complejidad de la realidad objetiva y resolver cualquiera de los complejos problemas que esta plantea” (p. 28).

La interdisciplinariedad no debe limitarse a una simple relación entre contenidos, sino que su esencia radica en el carácter educativo, formativo y transformador, en la convicción y actitudes de los sujetos. El autor de esta investigación asume el concepto de interdisciplinariedad aborda por Fiallo, J., por considerar que concuerda con los aspectos de la investigación que se está realizando.

El principio de la interdisciplinariedad se tendrá presente al desarrollar la orientación familiar para la estimulación prenatal, a través de todos los agentes que laboran con la gestante, médico de familia, enfermera y promotores del programa Educa a tu hijo.

Epígrafe 3: Manual de estimulación de la comunicación oral en la etapa gestacional.
Objetivo: Orientar a la familia, de forma interdisciplinaria para la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal.
Este manual se basa en el principio de que la estimulación prenatal de la comunicación oral es necesario tener en consideración que el cerebro humano está formado por células, neuronas, las cuales forman redes y conexiones, es decir, la sinapsis. Mientras mayor sea el número de conexiones neuronales que se produzcan, mayores serán las capacidades que se desarrollen en el cerebro, órgano que construye a un organismo y se construye a sí mismo. Por tales razones, los entes que intervienen en la primera infancia deben orientar a la familia la iniciación de la estimulación prenatal a temprana edad gestacional con el propósito de garantizar que se realice la mayor cantidad de sinapsis neuronales.
Se utiliza la estimulación del órgano que se considera importante en dicha estimulación es el oído, primer órgano funcional en la vida fetal, alrededor de las 16 semanas funciona en su capacidad, entonces el feto puede ser capaz de reaccionar ante ciertos estímulos sonoros como la voz de la madre, los latidos de su corazón, su respiración, una música suave, entre otros. Esto se debe a que el sonido opera como un neurotransmisor interactivo actuando directamente sobre el sistema neurovegetativo celular e hipofisiario del feto. Tales razones, confirman la necesidad de que la familia pueda discernir y determinar qué momentos aprovechar para comunicarse con el mismo.
La vista también es posible estimularla desde el período gestacional, a partir de las 16 semanas aproximadamente. Desde esta temprana etapa el feto puede percibir los fotones de luz que llegan a través de la pared abdominal de la madre, siguiendo la vía por el nervio óptico hasta la corteza cerebral, lo cual estimula su retina ocular. Para esta estimulación se pueden emplear diferentes objetos lumínicos.
El analizador táctil es viable estimularlo alrededor de la sexta semana de gestación. Los estímulos que percibe el feto del exterior, como resultado de diferentes presiones, genera oscilaciones que se transmiten a través del líquido amniótico los

cuales son captados por los nervios periféricos de su piel, trasladados a la médula espinal y por último al cerebro. Esto propicia que se produzcan cambios físicos en la posición y deslizamiento del bebé dentro del vientre materno, lo que contribuye a su vez, de manera incipiente, al fortalecimiento de los huesos y músculos en formación

Áreas de desarrollo que se benefician con la aplicación del Manual para la estimulación prenatal en la etapa gestacional.

Los estudios realizados acerca de los efectos de la comunicación en la estimulación de los analizadores, durante la etapa prenatal, evidencian que influyen, además, en las diferentes: emocional, intelectual, lingüística y motriz. En tal sentido, desde el punto de vista emocional le permite expresar sentimientos y emociones hacia los padres con movimientos de brazos y piernas, a su vez modifica estados de ánimo dando pataditas, riendo, sacando la lengua, entre otros y fortifica el vínculo entre la madre, el padre y el bebé.

Respecto al área intelectual, beneficia el desarrollo de la memoria, favorece el oído e incrementa el establecimiento de conexiones neuronales. Desde el punto de vista del área lingüística propicia la estimulación de la audición, introduce ritmos, tonos, tiempos, entre otros y le permite discriminar los sonidos. También el área motora se beneficia considerablemente porque le estimula el desarrollo de acciones motrices, propicia la realización de gestos faciales y momentos de relajación del cuerpo. En tal sentido, varios investigadores le conceden gran importancia no solo a las áreas de desarrollo, sino también para la salud física y psíquica y para su adaptación a la vida.

Por ello, los agentes educativos deben orientar a la familia acerca de las ventajas que tiene para el bebé la estimulación, aun antes del nacimiento, entre las que se encuentran: La relación comunicativa que establece con su mamá, papá u otro familiar antes de nacer a través de sus movimientos. Aprende a diferenciar los sonidos y ruidos del útero, así como los del mundo exterior. Presta atención en el momento que ocurre el estímulo y reacciona ante él. Asimila que los sonidos tienen significados y sirven para comunicarse.

Reconoce la voz de la madre u otro familiar que participe sistemáticamente en su estimulación. Permite la relajación de la gestante lo que provoca un estado placentero en el bebé. Involucra al padre y demás miembros de la familia fortaleciéndose los vínculos afectivos entre ellos. Resulta imprescindible que los

agentes educativos orienten a las embarazadas acerca del desarrollo cerebral de su futuro bebé en la etapa prenatal, es necesario que las mismas comprendan que para perfeccionar este proceso y garantizar una estimulación adecuada de la comunicación debe mantener un estado de salud y emocional positivo.

Deben conocer que sus experiencias durante la etapa y la estimulación que desarrollen determinan, favorablemente o no, los períodos posteriores del desarrollo del nuevo ser humano, por lo que la misma es aceptada por la gestante.

Es preciso que estos agentes educativos intercambien con las familias y principalmente con la embarazada acerca de la importancia que tiene que al hablar con el futuro bebé se acerquen al máximo al vientre de la madre. Otro aspecto de relevancia que la gestante debe conocer es que la utilización de la estimulación durante el trabajo de parto facilita y hace más placentero el mismo.

Es necesario que concienticen que su vientre es la única vía de estimulación que tienen y es una experiencia vivida por la gestante,18 por lo que la comunicación debe ser con voz clara, pausada y en un momento de tranquilidad. Esto permite comprender que la estimulación ha de iniciarse desde antes del nacimiento y no a partir de los tres o cuatro años, como generalmente se concebía. Es preciso que la familia conozca que la estimulación no debe concluir luego del nacimiento del bebe, sino que esta debe enriquecerse e intensificarse con nuevas acciones comunicativas en las que se empleen los signos no verbales y verbales.

En la estimulación de la comunicación prenatal las acciones y técnicas que contribuyen a su desarrollo resultan de gran apoyo para los adultos. Los agentes educativos pueden orientar a las familias el empleo de acciones para la estimulación prenatal de la comunicación, en tal sentido, pueden sugerirle:

Realizar los ejercicios de estimulación de la comunicación en cualquier momento siempre que sea en un ambiente adecuado y se puede ejecutar con una duración de 5 a 7 minutos como mínimo. Hablar con el futuro bebé con diferentes tonos de voz, pero sin gritar, al hacerlo la familia, principalmente el papá, deberá acariciar el vientre de la mamá durante su descanso, el aseo personal, la alimentación, en los intercambios sociales y familiares, entre otros. Tararear la misma canción cada vez que terminen una comunicación con el bebé. Colocar cerca del vientre una música suave, preferiblemente instrumental y música infantil. Para la estimulación de los analizadores desde la gestación pueden emplearse diversas técnicas y medios:

Auditiva: Propiciar la producción de sensaciones mediante la música, voces, marugas, sonajeros, entre otros, para que queden grabadas en él, esto remite que una vez nacido recuerde ese estado placentero que vivió durante su formación. El empleo de esta técnica puede comenzar alrededor de las 16 semanas, esto permitirá que al nacer logré relajarse con la música que escuchaba dentro del vientre, así como reconocer y diferenciar la voz de la mamá, el papá u otros sonidos. La audición es uno de los sentidos que conecta al bebé con el mundo exterior y a su vez es uno de los que más se pueden estimular, ya que el aparto auditivo del bebé se desarrolla aproximadamente a las 14 semanas de gestación, siendo entonces cuando empieza a captar los sonidos externos e internos. El sonido opera como un neurotransmisor interactivo actuando directamente sobre el sistema neurovegetativo celular e hipofisiario del feto, dejando impreso un registro a modo de huella. Por ejemplo, las sensaciones producidas por la música van a quedar grabadas en el futuro bebé, que lo remitirá una vez nacido a ese estado placentero que vivió durante su gestación.

Visual: Al igual que la anterior se recomienda comenzar su utilización más menos a las 16 semanas de gestación. Se sugiere estimular al bebé con la utilización de la luz artificial y natural, para ello se puede emplear una linterna u otro objeto lumínico que será colocado en el vientre de la futura mamá o muy cerca de él, en dependencia de la intensidad de la luz.

La repetición de esta técnica propiciará en el bebé una mejor discriminación visual durante la infancia temprana. Se realiza en forma más efectiva con la utilización de la luz artificial y natural. Los fotones de luz que llegan al feto a través de la pared abdominal de la madre estimulada la retina ocular, siguiendo la vía por el nervio óptico hasta la corteza cerebral, lo cual le permitirá al bebé en edad temprana una mejor discriminación visual, así como una mejor orientación y dirección.

Táctil: La estimulación de este analizador puede realizarse a través de diferentes instrumentos como masajeadores, vibradores, con texturas, que pueden ser colocados a nivel del dorso fetal, a través del vientre materno. Esto genera diferentes reacciones que dan origen a movimientos del feto contribuyendo a su vez, de manera incipiente, al fortalecimiento de los huesos y músculos en formación. De ahí la necesidad de que la familia aplique estás técnicas de estimulación.

Es importante que los agentes educativos, en especial las familias concienticen la importancia de estimular la comunicación en la etapa prenatal y su significación para su desarrollo ulterior. Sin duda alguna, la gestación es un momento propicio para realizar la estimulación desde el más temprano período de la vida, al favorecer el desarrollo de las células cerebrales,19 la que requiere continuidad después del nacimiento del bebé, esto contribuirá significativamente a su desarrollo integral y a la formación de su personalidad.



Manual para las familias

Estimulación en la etapa gestacional.

Autor: Lic. Freddy Matos Ramos

Índice

Introducción……..3
Relajación y comunicación…….4
Relajación e interiorización del cuerpo……5
Volver al útero…… 7
Relajación y evocación……..……7
Conversemos contigo…… 8
Estás sano……9
Estímulos afectivos para el bebé…… 9
Cómo te imagino (estimulación afectiva) ……10
Nos abrazamos (estimulación afectiva) ……11
Hagamos sonidos con el cuerpo (estimulación auditiva)……11
Me gusta acariciarte (estimulación afectiva)……..12
Te contaré un cuento (estimulación auditiva y afectiva)……..13
Sonidos graves (estimulación auditiva)……..…15
La orquesta de los sonidos graves…… 16
Equilibrando (estimulación de movimiento)……17
Sigamos haciendo equilibrio…… 17
Me gusta sentirte (estimulación afectiva)……18
Ejercicios de puño (estimulación táctil)……19
Aprendamos a contar (estimulación táctil)…… 19
Prendiendo y apagando (estimulación visual) …….. 20
Hablando con papá (estimulación afectiva) …….. 21
Bailemos (estimulación de movimiento) …… 21
Meciendo al bebé (estimulación táctil) ……22
Jugando con las manos (estimulación táctil) …… 23
Respirando juntos (estimulación afectiva) …….. 23
El contacto con el tacto (estimulación afectiva) …… 24
El cono de los sonidos (estimulación auditiva) …… 25
La hamaca (estimulación táctil) …… 26
Caminando (estimulación de movimiento) …… 26
Bibliografía …… 27

Introducción

El concepto *estimulación prenatal* es resultado de años de investigación, acerca del desarrollo humano antes del nacimiento, con base en los principios de la estimulación temprana. La *estimulación prenatal o intrauterina*, se refiere a las técnicas físicas y de relajación aplicadas por padres o cuidadores durante la gestación, con el objetivo de favorecer el desarrollo del sistema nervioso, la comunicación y los vínculos afectivos con la madre, el padre o ambos, en los mejores casos. De este modo, se observa al bebé como un ser con características propias y únicas, capaz de actuar y reaccionar en el vientre de su madre.

También se ofrecen espacios de relajación física y mental para la madre, y se brinda apoyo emocional y de pareja para el disfrute del embarazo. Con el presente manual se pretende dotar a las familias de actividades para brindar relajación y estímulos afectivos y sensoriales a mujeres durante el embarazo. Antes de empezar el trabajo con mujeres embarazadas, se sugiere leer y revisar el contenido de esta obra, para facilitar la comprensión y el desarrollo de las actividades recomendadas.

Relajación y comunicación

Material

• Música clásica o tranquila.

• Colchoneta.

• Silla.

Duración

30 minutos.

Desarrollo:

Elija música clásica que sea de su agrado. Acuéstese sobre una colchoneta o siéntese cómodamente en una silla, y luego piense cómo es su bebé; concéntrese y escuche la música. Se recomienda practicar la actividad durante todo el embarazo o por lo menos una vez a la semana durante los primeros meses. La constancia le hará entrar en armonioso diálogo con el bebé, por medio de la música.

Comunicación.

Material.

• Música clásica o tranquila.

Duración.

30 minutos.

Desarrollo.

Nos comunicamos con el bebé de diferentes maneras y, aunque es pequeño, él percibe si es aceptado o rechazado. Elija una frase tierna que exprese el amor que siente por su bebé. Piénsela o dígala en voz alta y repítala con frecuencia, de modo que forme parte de la charla cotidiana que entable con su hijo. Las afirmaciones pueden usarse en cualquier momento o cuando desee comunicarse verbal o mentalmente con el bebé.

Relajación e interiorización del cuerpo

Material: Música clásica o tranquila.

• Colchoneta.

Duración: 40 minutos.

Desarrollo.

Colóquese en posición cómoda, de preferencia acostada, con ropa ligera y sin zapatos. Ahora escuche los ruidos que hay a su alrededor y poco a poco concéntrese en su respiración (por aproximadamente un minuto). Ya que conoce el ritmo de su respiración, comience a hacer inhalaciones profundas: inhale (cuente hasta tres), sostenga el aire (cuente hasta tres) y exhale. Repita dos veces más. Deje las respiraciones profundas y vuelva suavemente a su respiración normal (esto le tomará alrededor de un minuto). Ahora imagine todo su cuerpo, como si lo viera desde arriba, poco a poco, desde la cabeza hasta llegar a los pies. Sienta cómo está presionando el suelo y trate de percibir cada dedo, uno por uno: primero los del pie derecho (por un minuto) y luego los del izquierdo (por un minuto más).

Posteriormente, doble hacia adentro los dedos de los pies y manténgalos así por cinco segundos, para luego extenderlos nuevamente por cinco segundos. Recorra mentalmente sus pies: primero las plantas y luego los empeines, sintiendo cómo pesa la tela sobre ellos y cómo la sangre hormiguea mientras los recorre; después, avance poco a poco hasta los tobillos, y advierta la presión de la tela sobre ellos.

Ahora intente tocar con la punta del pie el tobillo, elevándolo hacia delante con fuerza por cinco segundos, y después estire con fuerza hacia atrás por cinco segundos más, y relájese. Continúe el lento recorrido mental por la pierna hasta la rodilla, sintiendo la circulación de la sangre y cómo está ubicada la pierna: si está asentada o elevada. Ahora tense los músculos desde la rodilla hasta el tobillo (por cinco segundos) y relájelos. Explore imaginariamente por la rodilla hasta los glúteos y deténgase en la cadera. Percátese del peso de las piernas presionándolas contra el suelo; contraiga desde la cadera hasta la rodilla (por cinco segundos) y relaje.

Siga la exploración mental por el abdomen hasta el pecho, percibiendo el peso de la ropa sobre ellos. Atienda el palpitar del corazón (por 20 segundos), cómo se inflan y desinflan sus pulmones (por 20 segundos), el bombeo de la sangre hacia todo el cuerpo (por 20 segundos), y el movimiento del intestino haciendo la digestión (por 20 segundos). Continúe por toda la espalda y perciba cómo presiona el lugar donde está apoyada.

Ahora diríjase mentalmente hacia los brazos, desde el hombro hasta el codo, y no te lo liviano que es. Contraiga desde el codo hasta el hombro con fuerza (por cinco segundos). Descienda por el codo hasta la muñeca y sienta el fluir de la sangre. Ahora sólo contraiga esta parte durante cinco segundos. Concéntrese en la muñeca, en el dorso de la mano y en la palma, y preste atención a los dedos de las manos: empiece por la mano izquierda (los dedos pulgar, índice, medio, anular y meñique) y prosiga con los de la mano derecha (meñique, anular, medio, índice y pulgar). Empuñe fuerte contrayendo sólo la mano, y mantenga así por cinco segundos; al terminar, relájese y repita el procedimiento con la otra mano.

A continuación, lleve su atención al cuello; luego por el mentón hacia los labios, y bordéelos; después hasta la nariz y por encima de ella para llegar a la frente, bordear los ojos y recorrer la frente de un lado a otro. Descienda por las mejillas hacia las orejas y deténgase un minuto para explorarla. Ahora contraiga los músculos de la cara con fuerza, haciendo las muecas que pueda: eleve los labios, mueva la nariz, frunza el ceño y eleve las cejas, cada movimiento durante cinco segundos; posteriormente relaje la cara.

Para finalizar dirija la atención a la cabeza y sienta cómo el cabello desciende con suavidad desde ella. Empiece a recorrerla lentamente desde la frente hasta la nuca (por 10 segundos). Después de este recorrido por el cuerpo, concéntrese en su respiración por dos minutos, abra los ojos antes de incorporarse y sentarse de lado. Es recomendable compartir sus experiencias y escribir lo que más le agradó de esta sesión. Esto ayuda a que desaparezcan los sentimientos molestos y se fijen los agradables. Puede repetir esta actividad las veces que desee en el transcurso del embarazo, aunque seguramente no experimentará las mismas sensaciones.

Volver al útero

Material:

• Música clásica o tranquila.

• Colchoneta.

• Imágenes del bebé en el útero.

Duración: 50 minutos.

Desarrollo.

Esta actividad es recomendable realizarla en pareja: la madre con el padre del bebé. Ubíquense en un lugar tranquilo, observen las ilustraciones de las dos páginas siguientes por 20 o 30 minutos, e imagínense que están viendo a su bebé. Mantengan las sensaciones. Después, recuéstense a escuchar la música durante 15 minutos, al tiempo que se concentran en las ideas y las imágenes que surgen espontáneamente. No se esfuercen en recordar nada; sólo dejen que las imágenes fluyan con libertad. Cierren los ojos e imaginen que la música les devuelve a la tibieza y humedad del útero.

Este ejercicio puede remover recuerdos del nacimiento o vida intrauterina, así que se sugiere sólo evocar sensaciones positivas. Quizá vislumbren un color, escuchen un sonido y perciban imágenes relacionadas con flotar en el líquido amniótico, con la sensación de haber retornado al útero.

Relajación y evocación

Material

• Música clásica o tranquila.

• Colchoneta.

Duración: 50 minutos.

Desarrollo.

Esta actividad induce a experimentar sensaciones de tranquilidad que probablemente se acompañen de recuerdos de la vida fetal. Es recomendable realizar la actividad en pareja y dedicándole el tiempo necesario para disfrutarla. Recostados sobre la colchoneta, cierren los ojos y hagan una o dos inhalaciones profundas; piensen que las inhalaciones les proporcionan energía y que con las exhalaciones se liberan de sentimientos negativos. Luego empiecen a concentrarse en su respiración habitual y en sus sensaciones corporales, procurando atraer a la mente sólo estas últimas.

Tomen conciencia de cada una de las partes de su cuerpo; perciban cualquier presión o dolor, y la forma en la que están colocadas. Aún recostados y con los ojos cerrados, permitan que sus mentes viajen a la deriva (cinco minutos). Imagínense que van por la orilla de un río. Escuchen cómo golpea el agua en las rocas y el sonido rítmico del río; sientan cómo el viento acaricia con suavidad su cara. Ahora

vislúmbrense girando hacia la derecha y miren el prado, en el que se encuentran margaritas, tulipanes y rosas silvestres; observen sus colores. Vean los árboles que hay más allá. El lugar es tan hermoso que deciden acostarse sobre la hierba. Elijan uno de todos los árboles y flores que están a su alrededor. Piensen que son una semilla en el interior de la planta; el lugar es húmedo, fresco y delicioso, por lo que experimentan seguridad y tranquilidad.

Cada uno ve cómo su cuerpo crece dentro de la planta, y célula por célula aumenta de tamaño hasta hacerse cada vez más grande. Poco a poco regrese cada quien a su cuerpo. Muevan primero los dedos de manos y pies, y posteriormente sientan cada una de sus partes. Cuenten hasta 10, abran los ojos y tomen conciencia del entorno (30 segundos). Al finalizar, siéntense y mantengan en su mente los recuerdos de esta experiencia.

Conversemos contigo

Material: Música clásica o tranquila.

Duración: 30 minutos.

Desarrollo.

Es recomendable que los padres hablen todos los días con su bebé no nacido, aunque sea unos minutos, con un lenguaje tierno y afectuoso. Tienen que procurar no expresarse como bebés ni usar tonos duros o gritar. Asimismo, no deben inquietarse si no saben qué decirle al bebé. Hablen con el bebé sobre su trabajo, necesidades, deseos, lo mucho que lo esperan y lo felices que se sienten de que esté con ustedes. Recuerden que también es posible comunicarse con el pensamiento, así que usen esta modalidad en lugares públicos. Es muy importante que el padre participe tan activamente con la madre. Repitan todos los días este ejercicio.

Estás sano.

Material: Música clásica o tranquila.

• Diario personal.

Duración: 40 minutos.

Desarrollo.

Siéntese durante 30 minutos en un lugar cómodo. Cierre los ojos y pregúntese en cuanto a la salud y seguridad del bebé: ¿qué es lo que más temor le inspira?, ¿qué miedos tiene? y ¿cuál es el más profundo de ellos? Durante unos minutos deje que las diversas respuestas pasen por su cabeza, y después abra los ojos y escriba sus

miedos en el diario personal; anote todas las respuestas que se le ocurran. Acaricie con suavidad su vientre descubierto, e imagine a su bebé sano y hermoso flotando con placer en el líquido amniótico. Cuente mentalmente los dedos de sus manos y pies, y observe sus brazos, piernas, pecho y cabeza. Cuando esta imagen se haya vuelto nítida, repita: “estás sano y entero”. Converse de sus temores con el médico y con otras madres; sus experiencias podrán disipar estas dudas.

Estímulos afectivos para el bebé.

Material: Música clásica o tranquila.

• Diario personal.

Duración: 30 minutos.

Desarrollo.

Esta actividad es el punto de partida para la estimulación en pareja, dirigida al bebé. Escriban en su diario personal lo siguiente:

• Dos frases o palabras afectuosas con que se dirigen a la madre.

• Dos frases o palabras afectuosas que le expresan al padre.

• Dos frases o palabras que les hubiera gustado que les dijeran en su infancia.

• Dos frases con las que identifican a su bebé.

Lean las ocho frases y escojan individualmente una que los identifique con su bebé y les guste para usarla como “palabra clave”. Ésta será su carta de presentación con el bebé, y la pronunciarán siempre con afecto y emotividad al hablar o jugar con él, cuando se saluden y se despidan. Cuando ya tengan en brazos a su bebé, digan su respectiva palabra clave y observen la reacción del pequeño: quizá él busque la fuente del sonido, abra los ojos, se tranquilice, deje de llorar o sonría. Esta reacción demostrará que el bebé identifica auditivamente a quienes le han brindado amor desde antes de nacer: sus padres.

Cómo te imagino (estimulación afectiva).

Material: Música clásica o tranquila.

• Sillas o colchoneta.

Duración: 40 minutos.

Desarrollo.

Es preferible que en esta actividad participe el padre del bebé, y que junto con la madre dispongan de tiempo suficiente. Sentados en una posición cómoda, observen el abdomen de la madre y visualicen al bebé dentro. Imaginen su cabeza, sus ojos cerrados, su nariz pequeña y su delicada boca que se abre y cierra con

lentitud. Recorran mentalmente su pecho y ese fuerte corazón que late con energía; sientan el calor y la ternura con que palpita. Observen su maravillosa determinación de crecer y vivir, y las ganas de compartir con ustedes ese sentimiento.

La madre debe detener el aliento para escuchar cómo el corazón del bebé armoniza con el ritmo de sus propios latidos. Notará que al respirar con profundidad produce suaves movimientos en el vientre. Ambos imaginen los brazos y dedos del bebé en movimiento, y sus delgadas piernas mecidas por el bamboleo del agua, y luego cuenten los deditos de sus pies. Manténganse contemplando a su bebé por un momento más. Luego miren la habitación en donde se encuentren. Pueden seguir en esa posición por un tiempo más, mientras disfrutan la sensación que evocaron. Repitan esta actividad las veces que deseen.

Nos abrazamos (estimulación afectiva).

Material: Música clásica o tranquila.

• Colchoneta.

Duración: 30 minutos.

Desarrollo.

Esta actividad es para que los padres dialoguen con su bebé, estén atentos a sus respuestas e intercambien apoyo y afecto. Se les recomienda adoptar una posición cómoda que sea posible mantener por 10 minutos. Es mejor iniciar con el padre frente a la madre. Abrácense de cinco formas diferentes. Primero, el padre tiene que sostener a la madre en sus brazos mientras ella conversa acerca de lo que ha llevado a cabo durante el embarazo hasta este momento; luego toca a la madre brindar soporte al padre. Mientras estén abrazados, perciban la seguridad que deriva de ese apoyo físico y afectuoso. Después, cambien de posición: sentados, uno al lado del otro, uno de espaldas al otro, o de otras formas que se les ocurran, y repitan los cinco abrazos igual que la vez anterior.

Hagamos sonidos con el cuerpo (estimulación auditiva).

Material: Colchoneta.

Duración: 30 minutos.

Desarrollo.

El bebé vive en el vientre de la madre, inmerso en un mundo de sonidos. Está acostumbrado al ruido como parte de su hábitat. Los sonidos que escucha son un elemento estimulador de su atención y curiosidad, sobre todo cuando se salen de lo que para él es habitual y se convierten en una experiencia de juego. Platíquenle

a su bebé que van a jugar con él “haciendo ruidos”. Preséntenle los sonidos uno por uno y, si así lo desean, indíquenle de qué clase son:

• *Sonidos del habla y de la boca*. Son resultado de la combinación de las 28 letras del alfabeto y se acompañan de ritmo, entonación y melodía, para provocar una variedad de emisiones que le dan sentido al habla; son también los onomatopéyicos, que se producen al imitar sonidos de animales o de la naturaleza: *muu, kikirikí, bee, guau guau, miau miau, glu glu, brr brr, shhhhh,* etcétera.

• *Sonidos corporales*. Son los que se originan con movimientos del cuerpo: aplausos, golpes en el vientre, tronido de los dedos, o palmadas, entre otros.

• *Sonidos del organismo*. Son los que se producen durante los procesos digestivos, respiratorios y cardiacos: el paso de saliva, la respiración rítmica, los latidos del corazón (tum-tum) o la circulación sanguínea (sshh-sshh). Sean creativos y dinámicos. Recuerden que se trata de jugar con el bebé y, sobre todo, ríanse mucho. Pongan mucha atención a las reacciones del bebé; tal vez haya sonidos que le gusten más que otros, y ustedes podrán notarlo por sus respuestas. Repitan esta actividad cuantas veces quieran a lo largo del embarazo.

Me gusta acariciarte (estimulación afectiva).

Material: Música clásica o tranquila.

• Colchoneta.

Duración: 30 minutos.

Desarrollo.

Las caricias al vientre de la madre son expresiones de amor y aceptación al bebé, y una forma de incorporarlo al grupo familiar. Pueden participar el papá, la mamá y los hermanos. Apoye con ternura sus manos sobre el vientre y acarícielo, de preferencia sin hablarle al bebé. Durante esta actividad trate de proyectar amor y aceptación. Procure alargar esta sesión y trate de relajarse al ritmo de las caricias.

Te contaré un cuento (estimulación auditiva y afectiva).

Material: Música clásica o tranquila.

• Colchoneta.

Duración: 30 minutos.

Desarrollo.

La música clásica crea un ambiente relajado que permite la captación con tranquilidad. A continuación, se presentan dos modelos de lecturas apropiadas para el bebé, pero también está en libertad de elegir otro poema infantil alegre y divertido.

No se recomiendan temas violentos ni dramáticos. Pueden involucrarse la mamá, el papá o los hermanos, ya sea por la tarde o en la noche. Procuren modular el tono de su voz a la situación del cuento.

Cuento: La oruga amarilla.

Una oruga amarilla.
debajo de un árbol vivía.
Ahí, en medio de una rama,
estaba escondida su cama.
Comía pedazos de hojas,
Tomaba el sol en las gotas.
Le gustaba salir a mirar,
a los bichitos que salen a volar.
Un día pasó algo raro.
Sintió su cuerpo hinchado.
No quiso salir a mirar,
sólo quería descansar.
Se puso camisa de seda,
se escondió en una gran higuera.
Todo el invierno durmió,
y con alas se despertó.

Cuento: La margarita blanca.

Era una vez una margarita blanca que vivía debajo de la tierra, en una casita caliente, tranquila y oscura. Un día oyó unos golpes muy suaves en la ventana: chas, chas, chas.

—¿Quién llama?

—Es la lluvia.

—¿Qué quiere la lluvia?

—Entrar en la casa.

—¡No se pasa!, ¡no se pasa!

—dijo la margarita blanca que tenía mucho miedo del frío, porque era invierno. Pasaron muchos días y oyó otros golpecitos en la puerta: tun, tun, tun.

—¿Quién llama?

—Es el sol.

—¿Qué quiere el sol?

—Entrar en la casa.

—¡Todavía no se pasa!, ¡todavía no se pasa! —dijo la margarita blanca y se durmió tranquila. Después de muchos días, volvieron a tocar a la puerta y a la ventana: tun, tun, tun; chas, chas, chas.

—¿Quién llama?

—Son el sol y la lluvia, la lluvia y el sol.

—¿Y qué quieren el sol y la lluvia, la lluvia y el sol?

—Queremos entrar, queremos entrar.

—Pues pasen los dos —dijo la margarita blanca. Y abrió una rendijita, por donde se escurrieron el sol y la lluvia dentro de la casa. Entonces la lluvia le tomó por la mano derecha, y el sol le tomó por la mano izquierda, y tiraron de la margarita blanca, y tiraron y tiraron hasta arriba y dijeron:

—¡Margarita, Margarita, asoma tu cabecita!

La margarita blanca pasó su cabecita a través de la tierra y se encontró en un jardín precioso, con mariposas, pájaros y niños que jugaban a la rueda cantando:

Ya sale margarita.
vestida de percal.
con sombrero amarillo
y verde delantal.
Caracol, caracol,
saca los cuernos al sol.
Con la cara empolvada
margarita ha salido
a correr por el prado
luciendo su vestido.
Caracol, caracol,
para cada cuerno
te traigo una flor.

Y la margarita se abrió toda blanca con su moñito rubio. Y fue feliz.

Lean el cuento unas 15 veces durante un mes y conforme pasen los días procuren distinguir si las palabras o frases producen alguna respuesta del bebé, ya sea con movimiento, calma o pataleo. Identifiquen si se relaciona con el tono de su voz y con la situación que narran. Esta reacción demostrará que el bebé interactúa con ustedes y reacciona de forma particular a diferentes cuentos o ante distintos

narradores. Continúen contándole cuentos; la clave es la repetición y la calidad de la narración.

Sonidos graves (estimulación auditiva)

Material: Música clásica o tranquila.

• Colchoneta.

• Botellas chicas de plástico, llenas de piedras, tierra y clavos.

• Botella chica de plástico vacía.

• Dos palitos.

Duración: 15 minutos.

Desarrollo.

Los sonidos graves son más intensos que el habla. Por lo tanto, ésta va a ser una actividad ruidosa pero divertida en la cual se ocupará todo el tiempo un “instrumento musical”.

Siéntense cómodamente, saluden al bebé y platíquenle algo sobre los sonidos que escuchará (por ejemplo, díganle “vas a escuchar una botella llena de clavos”). A continuación, sacudan la botella llena de piedras, o con los palitos golpeen de manera rítmica la botella vacía, a una distancia aproximada de 15 centímetros del vientre, primero con lentitud y gradualmente con más celeridad, para luego poco a poco regresar a la velocidad inicial. Cuando hayan finalizado, deben preguntar al bebé si le gustó, dedicarle unas palabras amorosas y despedirse de él. Repitan la actividad, pero con diferentes instrumentos.

La orquesta de los sonidos graves.

(estimulación auditiva).

Material: Música clásica o tranquila.

• Colchoneta.

• Botellas chicas de plástico, llenas de piedras, tierra y clavos.

• Botella chica de plástico vacía.

• Dos palitos.

Duración: 15 minutos.

Desarrollo.

Aquí se retomarán los instrumentos usados en la actividad “Sonidos graves”, en todas las combinaciones posibles, y se producirán sonidos lentos, rápidos o al ritmo de la música de fondo. La madre puede iniciar con un instrumento y el padre responder con otro, a fin de establecer un diálogo entre sonidos distintos. Otra

opción es empezar con un instrumento, continuar con otro y finalizar con uno diferente. Se recomienda que no hablen y que estén muy atentos a las reacciones del bebé.

Equilibrando (estimulación de movimiento).

Material: Música clásica o tranquila.

• Colchoneta.

Duración: 15 minutos.

Desarrollo.

La maduración del *vestíbulo* —estructura del oído que se favorece con los progresivos movimientos del bebé mientras crece—, tiene que ver con el sentido del equilibrio y el desplazamiento, pero también con el aprendizaje. La adquisición de conocimientos en la infancia se basa, primero, en el dominio del propio cuerpo, y luego en el de las posibilidades de movimiento y exploración que éste permita.

Si el equilibrio se desarrolla de manera adecuada, el infante es capaz de moverse sin problema, y por lo tanto conocer y aprender, pues el aprendizaje es resultado de una progresión de sucesos que debe tener soportes firmes. Mézase suavemente al ritmo de la música o al ritmo del latido de su corazón, ya sea en una mecedora o sentada en una colchoneta blanda.

Se recomienda realizar este ejercicio a media mañana o a media tarde, lejos de cualquier comida, para evitar mareos o náuseas. Si aun así sufre alguna de esas molestias, haga respiraciones frecuentes. No se esfuerce.

Sigamos haciendo equilibrio.

(estimulación de movimiento).

Material: Música clásica o tranquila.

• Cinta adhesiva.

• Gis.

Duración: 15 minutos.

Desarrollo.

Ejercitarse es favorable para su relajación y buen estado físico. Trace líneas con gis o cinta adhesiva en el piso, y luego camine sobre ellas poniendo un pie tras otro, haciendo equilibrio. Por seguridad sujétese del brazo de un acompañante. Una variante consiste en desplazarse por un borde un poco más alto, ayudándose también de otra persona. Haga este ejercicio con los ojos abiertos o cerrados y con los brazos estirados.

Me gusta sentirte (estimulación afectiva).

Material: Música clásica o tranquila.

• Colchoneta.

• Aceite natural.

Duración: 15 minutos.

Desarrollo.

El bebé es muy activo en el vientre, y combina sus etapas de actividad con sueño y descanso, pero hay momentos en los que está mucho más activo y sus movimientos constituyen una forma de diálogo con la madre. Las caricias en el vientre pueden significar masajes calmantes. El bebé siente si alguien mueve su mano por el abdomen, y responde con movimientos o tranquilidad. Si el padre participa hablándole suavemente, también reacciona a este juego. Además, las mujeres que reciben masajes durante su embarazo tienen partos más fáciles y una respuesta más cálida por parte del bebé.

Cuando el bebé dé patadas, correspóndanle con suaves caricias en el abdomen de mamá, de manera que refuercen el intento de comunicarse con él en un diálogo afectuoso a base de caricias a lo largo y ancho del vientre, circulares o una mezcla de todas. Si sienten que el bebé está inquieto, es ideal utilizar este recurso todas las noches para lograr que la madre se relaje, motivando el sueño y descanso. Se recomienda cantarle suavemente y usar un aceite natural ligero para facilitar los movimientos de la mano.

Ejercicios de puño (estimulación táctil).

Material: Música clásica o tranquila.

• Colchoneta.

Duración: 30 minutos.

Desarrollo.

Siéntense sobre la colchoneta, con música de fondo. Empiecen respirando rítmicamente, hasta sentirse cómodos y relajados. El padre, con la mano en forma de puño, presionará con suavidad unas 30 veces el costado derecho del vientre materno, en dos lugares diferentes: la parte alta y la parte baja, siguiendo el ritmo de la música. Luego hará lo mismo en el costado izquierdo. Repitan el ejercicio tres veces por lado. Con este ejercicio se establece un diálogo táctil con el bebé, que mejora con las repeticiones. Por ello, es necesario que realicen la actividad en

diferentes sesiones, que observen todas las respuestas y traten de comprender qué significado tienen.

Aprendamos a contar (estimulación táctil).

Material: Música clásica o tranquila.

• Colchoneta.

• Lámpara de mano.

Duración: 30 minutos.

Desarrollo.

Durante esta actividad los padres observarán numerosas reacciones del bebé, las cuales demuestran la atención que él presta al ejercicio y lo complacido que se siente. Inicien apuntando al vientre con la luz de la lámpara, y díganle al bebé que van a contar. Primero digan uno y presionen una vez, como si estuvieran imprimiendo su mano en el vientre; luego digan dos y presionen dos veces en el mismo lado, pero sobre diferentes sitios. Con la lámpara de mano, apunten el lugar donde están presionando y sigan el trayecto de las presiones. Continúen así con los otros números, hasta llegar al 10. Pongan atención a todas las reacciones del bebé. Para acompañar esta actividad se recomienda entonar la siguiente rima:

Uno, dos, tres, puñetitos.

Cuatro, cinco, seis, puñetitos.

Siete, ocho, nueve puñetitos.

Diez puñetitos son.

Prendiendo y apagando (estimulación visual).

Material: Música clásica o tranquila.

• Colchoneta.

• Lámpara de mano.

• Papel celofán de color verde.

Duración: 30 minutos.

Desarrollo.

En determinadas condiciones, el bebé puede percibir algo de luz a través de las paredes abdominales de la madre. Siéntense cómodamente sobre la colchoneta. Si lo desean, más adelante cambien de posición. Aunque en este ejercicio participan la madre, el bebé y el padre, éste sobre todo es quien debe seguir las recomendaciones que se dan a continuación. Forre la linterna con el papel celofán, para disminuir un poco la intensidad de la luz.

Después de encender la lámpara, coméntele al bebé que va a jugar con él, hablándole a la altura del vientre. Apunte la luz a la mitad del abdomen de la madre y dígale: “se prende”, manteniéndola así por cinco segundos. Luego apague la lámpara por otros cinco segundos, y avísele: “se apaga”. A continuación, coloque la linterna en la parte inferior del vientre y repita: “se prende y se apaga”. Debe hacer esto en tres posiciones: arriba del vientre, en el centro y abajo. Siga esta secuencia en ocho repeticiones; probablemente el bebé comenzará a identificar la secuencia y dirigirá la mirada al lugar correspondiente. Motive al bebé con palabras alentadoras.

Recuerde que el padre se convierte en un modelo para el bebé y su influencia depende de lo significativo que sean los lazos de amor que haya creado. Se aconseja realizar este ejercicio de preferencia en la noche, en un cuarto en penumbra, para que el efecto de la linterna sobre el vientre sea más notable.

Hablando con papá (estimulación afectiva).

Material: Música clásica o tranquila.

• Colchoneta.

Duración: 30 minutos.

Desarrollo.

La presencia del padre es importante durante el embarazo; pero si está lejos, la madre puede solicitar apoyo de otras personas, o bien grabar su voz para que el bebé lo escuche. En esta actividad el padre le hablará al bebé y lo acariciará a través del vientre de la madre.

Observen su reacción y sientan cómo aprueba su presencia. Si es inquieto, es muy probable que se tranquilice; en cambio, si es tranquilo quizá demuestre su agrado por las caricias dando patadas hacia el lado de la cama o colchoneta que reconoce como el del padre. Pueden contarle lo que les sucedió en el día, o simplemente reforzar el gran cariño que sienten por él. Esta actividad ayudará para que el bebé advierta que es un individuo diferente de su madre antes del nacimiento, y se sienta deseado y amado.

Bailemos (estimulación de movimiento).

Material: Música clásica o de vals.

Duración: 30 minutos.

Desarrollo.

Los movimientos de la madre son percibidos por el bebé, y también son estimuladores del equilibrio. Para esta actividad se recomienda usar ropa cómoda, zapatos bajos o los pies descalzos sobre la alfombra o césped. Así podrá bailar siguiendo el ritmo de la música, desplazarse por toda la habitación y explorar con el baile todos los rincones posibles. Los movimientos de vals tienen como propósito mecer al bebé; procure no realizar giros muy rápidos ni muy complicados. Sólo déjese llevar por la música. El baile es una mezcla de percepción auditiva elaborada en movimiento, y es una actividad placentera de desplazamiento.

También es conveniente para liberar la presión de un día de trabajo, canalizar temores e iras, y para dejar fluir la alegría, gracias a los cambios en las pautas musculares que incluyen los movimientos. Si desea puede recurrir a otro tipo de música que le agrade, pero evite ritmos que molesten al bebé. Otra alternativa es realizar movimientos suaves sin cambiar de lugar, y con los ojos cerrados, concentrándose en el ritmo de la música y sintiendo cómo la melodía invade todo el cuerpo. Durante el baile, acaricie su vientre, efectúe movimientos circulares con el cuerpo y con todos sus segmentos: cabeza, muñecas, codos, brazos, tobillos, piernas, cadera. Continúe bailando hasta sentirse relajada y libre de tensiones.

Meciendo al bebé (estimulación táctil).

Material: Música clásica o de vals.

Duración: 30 minutos.

Desarrollo.

Mediante la respiración proporcionamos energía a nuestro cuerpo y al bebé. Respirar de manera rítmica y regular favorece el aporte de oxígeno a la sangre, y gracias a ello todo el cuerpo funciona mejor. La respiración rítmica ayuda a mantener la cabeza despejada y la mente despierta; los pulmones trabajan con mayor facilidad y los nutrimentos ingeridos llegan más rápido a las células. Para este ejercicio, procure ubicarse en un lugar amplio, bien ventilado y limpio, y sin interrupciones.

Sentada, ubique la mano en su abdomen mientras mira el vientre y piensa en el bebé. Imagine la posición en que se encuentra, los rasgos de su cara, cómo mueve sus brazos y piernas, cómo abre y cierra su boca y párpados. Cuando visualice al bebé totalmente, póngase de pie y acaricie su abdomen. Empiece a inhalar mientras mueve el abdomen hacia adelante; mantenga la respiración por tres segundos, y luego exhale con lentitud, contrayendo el abdomen.

Repita esta secuencia durante ocho minutos. Mediante este movimiento de mecedora, conéctese con los sentimientos de su bebé. Después, cierre los ojos y continúe con la respiración rítmica. Sienta cómo la energía acaricia con suavidad al bebé. Imagine que el aire es una luz tenue, que recorre el camino desde su nariz hasta los pulmones, luego se dirige a su corazón y éste la bombea hasta el organismo del bebé. Toque su vientre como si estuviera acariciando al bebé, desde la cabeza hasta los pies, al ritmo de las inhalaciones y exhalaciones, pues las caricias de este tipo favorecen la maduración del sistema nervioso.

Conforme avance en el ejercicio, percibirá sus movimientos fluidos y uniformes, y desarrollará un sentimiento de profunda comunión con su bebé. Practicando esta actividad con regularidad, será fácil relajarse y reforzar el vínculo con el bebé, quien probablemente se muestre más activo.

Jugando con las manos (estimulación táctil).

Material: Música clásica o tranquila.

Duración: 30 minutos.

Desarrollo.

Inicie la actividad saludando al bebé con la mano extendida y haciendo suaves y afectuosas presiones en el vientre. Con la palma de su mano, acaricie al bebé desde la cabeza hasta los pies, considerando que éste se halla en posición fetal, es decir, acurrucado, y arqueado con la espalda hacia afuera, dirigiendo la cabeza y las rodillas hacia el pecho. Deslice la mano por la cabeza del bebé, haciendo un movimiento circular; luego baje por la espalda hasta la pelvis y finalmente a los pies. Repita estos suaves masajes unas 30 veces, de preferencia por las noches, mientras visualiza al bebé y respira rítmicamente. Preste mucha atención a las respuestas que el bebé da a sus caricias, y recuerde despedirse al finalizar el ejercicio.

Respirando juntos (estimulación afectiva).

Material: Música clásica o tranquila.

Duración: 30 minutos.

Desarrollo.

Esta actividad es similar a “Meciendo al bebé”, aunque aquí las inhalaciones son por la nariz y las exhalaciones por la boca, acompañadas de la expresión “ah”. Siéntese en un lugar cómodo. Luego coloque una mano a unos 15 centímetros del abdomen materno, mírelo por unos tres minutos y visualice al bebé: sus brazos,

manos, piernas, pies y los rasgos de su cara. Después, póngase de pie, apoye las manos en el vientre y repita el ejercicio de “Meciendo al bebé”, pero al exhalar por la boca, deje salir un “ah” largo y sonoro.

Cuando haya armonizado con el ritmo del bebé, concéntrese en la entrada de aire y en cómo éste masajea con suavidad al bebé al mismo tiempo de que la madre se relaja. Perciba también cómo el aire sale con suavidad del cuerpo, como si estuviera limpiándolo. Este ejercicio tiene un efecto relajador y calmante, y favorece la comunicación entre madre e hijo. Recuerde que la energía proporcionada a su hijo por medio de la respiración puede provocar aumento en su actividad.

El contacto con el tacto (estimulación afectiva).

Material: Música clásica o tranquila.

• Colchoneta.

Duración: 30 minutos.

Desarrollo.

Esta actividad consiste en comunicar amor al bebé mediante mensajes corporales, a través del tranquilizador latido de su corazón y suaves caricias. Para ello, la madre debe colocarse en la posición más cómoda, es decir, sentada sobre la colchoneta, con los pies estirados. Comience la actividad saludando al bebé, después cierre los ojos e inhale y exhale al mismo ritmo. Haga ocho respiraciones iguales. Sienta cómo el aire entra y sale por las fosas nasales, mire cómo las costillas se expanden y perciba cómo el aire recorre sus pulmones.

Piense en su respiración. Ahora concéntrese en sus latidos cardiacos y conéctese con ese rítmico *tan, tan*. Apoye sus manos sobre el vientre y con suavidad recorra toda la superficie, tratando de que estos movimientos sean al ritmo del corazón. Continúe así por tres minutos. Después, desplace sus manos con suaves movimientos circulares por todo el vientre, presionando poco a poco y ligeramente con las yemas de los dedos. Realice presiones con la palma, un poco más firmes, por toda la superficie y al ritmo del corazón, unos dos minutos más; luego oprima el vientre con toda la mano. Finalmente repita a la inversa, es decir, pase de la presión de la mano a la presión de la palma, y del contacto de la palma a la presión con los dedos.

Termine deslizando las manos por todo su vientre. Abra los ojos y continúe atenta al ritmo del corazón. Respire con suavidad cinco veces más, y cambie de posición.

Se sugiere que exprese sus sentimientos al momento de acariciar y presionar su vientre.

El cono de los sonidos (estimulación auditiva).

Material: Música clásica o tranquila.

• Colchoneta.

• Cartulina.

Duración: 20 minutos.

Desarrollo.

Arrullen al bebé con una canción de cuna, que también podrán entonarle cuando nazca. Para empezar, elaboren el cono de los sonidos con una cartulina: basta con enrollarla y hacerle orifi cios laterales. Apoyen el cono sobre el vientre y canten, a través de él, una canción como la siguiente:

Estrellita dónde estás,
me pregunto qué serás.
Un diamante debes ser,
di si tú me puedes ver.
Estrellita si te vas,
di que no me olvidarás.

La canción tendrá un maravilloso efecto sobre el bebé después de que nazca. Si es posible, cántensela todos los días. No importa si no disponen de una voz melodiosa; lo primordial es demostrar que están presentes y que lo aman.

La hamaca (estimulación táctil).

Material: Música clásica o tranquila.

• Hamaca o colchoneta.

Duración: 20 minutos.

Desarrollo.

Ésta es una variante del ejercicio “La mecedora”, y consiste en desplazarse de un lado al otro en una hamaca, o moverse sentados de un lado hacia otro. Pueden cantarle al bebé como si lo estuvieran meciendo. Repitan este ejercicio con la mayor frecuencia posible.

Caminando (estimulación de movimiento).

Material: Música clásica o tranquila.

• Ropa cómoda.

Duración: 30 minutos.

Desarrollo.

Una de las recomendaciones más insistentes durante el embarazo es que la madre dedique tiempo diario a caminar. La caminata no sólo la mantendrá en forma, sino que oxigenará su cuerpo, la liberará de tensiones y la acondicionará para el parto. En este ejercicio varía la forma de desplazarse. Puede hacerse siguiendo una secuencia, por ejemplo: cinco pasos de frente, tres pasos de un lado, tres pasos del otro, dos pasos hacia atrás, y en varias repeticiones.

Epígrafe 4 Validación de la propuesta.

Análisis del criterio de expertos.

Criterio de expertos.

Pasos seguidos para el criterio de expertos:

Se Confeccionó un listado inicial de personas posibles de cumplir los requisitos para ser expertos en la materia a trabajar. Se consideró para la propuesta de los candidatos valorar las cualidades referidas por Crespo, T.

En este caso se analizaron 10 candidatos.

Se confeccionó un listado inicial de personas posibles de cumplir los requisitos para ser expertos en la materia a trabajar.

La muestra seleccionada (10 expertos), se caracteriza por tener experiencia en su labor como profesional, de ellos 5 son médicos del programa de atención a las gestantes.

Para determinar el coeficiente de competencia de los expertos se solicitó a los candidatos llenar una autoevaluación (Anexo 5) según su nivel de conocimientos en los temas relacionados con la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal, a partir de la cual se precisaron los coeficientes de conocimiento (kc) y de argumentación (ka), necesarios para determinar el nivel de competencia de los expertos y su selección final.

El resultado de la encuesta del coeficiente de conocimiento que poseen los expertos, se muestra en el (Anexo 6). El resultado de la encuesta del coeficiente de argumentación se muestra en el (Anexo 7).

Las respuestas dadas por los expertos se valoraron de acuerdo con una tabla preestablecida (Anexo 8). Según la cual los 10 obtienen un coeficiente alto, por lo que se decide tenerlos en cuenta a los 10 como expertos.

Procesamiento de la información obtenida por los expertos. Una vez seleccionados los expertos con los que se realizó el trabajo, se les enviaron los aspectos y categorías a evaluar previamente determinados por la investigadora en el trabajo de campo, a través de una tabla de Aspectos / Rangos de Valoración**.**

Los rangos de valoración son 5, es decir, muy adecuado, bastante adecuado, adecuado, poco adecuado y no adecuado, a los que se les asigna valor numérico del 1 al 5 en el mismo orden**.**

A cada experto seleccionado se le envió una copia del instrumento para que los valorasen. (Anexo 9).

Se analizan las siguientes valoraciones. (Anexo 10).

1. Referido a el objetivo general del manual: 10 expertos valoraron de muy adecuado (para un 100%).
2. Con respecto a la estructura del manual 1 experto la valoraron de muy adecuada (para un 10%), 7 de bastante adecuada (para un 70%) y 2 lo evalúan de adecuada, para un 20 %.
3. Relacionados con las actividades que se desarrollan en el manual para la estimulación de la comunicación oral en la etapa gestacional, 1 expertos valoraron el manual de muy adecuada (para un 10%), 8 de bastante adecuado (para un 80%) 1 de adecuada (par un 10 %).
4. Con respecto al trabajo con la interdisciplinariedad 7 expertos valoraron el manual de bastante adecuad0 (para un 70%) 3 de adecuado (para un 30%)
5. Valorando el trabajo con la estimulación de la comunicación, 6 expertos valoraron el manual de bastante adecuado (para un 60%) 4 de adecuado (para un 40%).

Los valores identificados aportan un alto nivel de significación de la concordancia de los expertos, lo que indica la validez de los indicadores propuestos. Expresando de muy adecuado.

Las sugerencias y recomendaciones que proponen se concretan en:

- Extender el manual a otras Consejos Populares.

Análisis de la Guía de entrevista a gestantes. (Anexo 4).

De 24 gestantes entrevistada, el 100 % plantean tener conocimiento sobre el tema. Refieren conocimientos de las diferentes técnicas que pueden emplear para la estimulación de la comunicación en la etapa prenatal. Estos resultados abundan

que son posibles por haber recibido capacitación acerca del tema, con muy buen criterio sobre los beneficios en la esfera psicológica y de salud integral

CONCLUSIONES

1. El proceso de orientación familiar para la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal se fundamenta en los postulados y principios de la escuela histórico- cultural, la que constituye la plataforma para el desarrollo de este proceso.
2. El diagnóstico realizado revela insuficiencias en el proceso orientación familiar para la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal, relacionadas con insuficientes acciones que se realizan y el insuficiente conocimiento que se posee sobre el tema.
3. El manual brinda una herramienta creativa y novedosa que permite el trabajo con la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal.
4. La valoración del manual por el criterio de expertos, permitió constatar un alto nivel de significación de la concordancia de estos respecto a la importancia de los aspectos evaluados, relacionados con el objetivo, estructura, actividades y relaciones interdisciplinarias.

RECOMENDACIONES

1. Divulgar en diferentes espacios de interacción científica la propuesta realizada.
2. Precisar desde la interdisciplinariedad el papel de cada uno de los involucrados en el desarrollo de la estimulación prenatal teniendo en cuenta las condiciones de Cuba.

BIBLIOGRAFÍA

Aguaiza, T. A. (2012). *La estimulación prenatal en mujeres adolescentes*. (Proyecto de Grado). Tulcán: Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Carchi: http://181.198.77.140:8080/handle/123456789/206

Aguilar Cordero, M. J., Vieite Ravelo, M., Padilla López, C. A., Mur Villar, N., Rizo Baeza, M., & Gómez García, C. I. (2012). La estimulación prenatal; resultados relevantes en el periparto. *Nutrición hospitalaria*, 27(6), 2102-2108. https://doi.org/DOI:10.3305/nh.2012.27.6.6019

Álvarez Lami, L., Fernández Collazo, L., Ferrer Sarmiento, A., López Betancourt, M., Capó Alonso, M. T., Regal Cabrera, N., Castellano Toro, G., Sardiñas Peña, Á., Pazo Quintana, T., Cabrera Díaz de Arce, I., Montesino Bejerano, E., Ochoa Barrientos, N., & Rodríguez Gómez, A. M. (2008). *Logopedia y foniatría*. Ciencias Médicas.

Anleu, G. (2013). *Estimulación Prenatal. En la capacitación al personal del Departamento de Psicología, Hospital Regional de Occidente San Juan de Dios*

Andrés Viloria, C., & Gutiez Cuevas, P. (2018). Oportunidad y continuidad de la educación prenatal. In J. C. Arboleda Aparicio (Ed.), *Educación prenatal y Pedagogía prenatal: Nuevas perspectivas para la investigación, la enseñanza y la formación.* (Vol. 1, pp. 25-56). Editorial REDIPE.

Araya Crisóstomo, S., Monzón, V. H., & Infante Malachias, M. E. (2019). Interdisciplinariedad en palabras del profesor de Biología: De la comprensión teórica a la práctica educativa. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 24(81), 403-429.

Arranz Betegón, Á. (2017). *Evaluación de un programa de intervención prenatal en embarazadas con fetos pequeños para la edad gestacional* [Tesis doctoral Universidad de Barcelona]. Barcelona.

Cabezas Salmon Mayelín (2019). La interdisciplinariedad: una reflexión para el desempeño profesional del maestro primario en las escuelas rurales. *Ideação* 20 (1) p. 42–53 https://saber.unioeste.br/index.php/ideacao/article/view/23071

Cabezas Salmon Mayelín (2022). Orientación familiar en comunidades vulnerables: papel de los factores comunitarios y agentes educativos en Cuba. *Maestro y sociedad* 19, (4), pp. 1030-1038 https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/5652

Castro, Pedro. (2005) *El trabajo con la familia en el sistema educativo*. Editorial Pueblo y Educación, página 37-38.

Cedeño Caicedo, A. (2020). *Guía de actividades prácticas para la estimulación prenatal por medio de la música, el sonido y el canto a partir del segundo trimestre de gestación* Bellas Artes. Institución Universitaria del Valle].

Cobas Ochoa, C. L. (2010). *Temas logopédicos para los docentes*. Editorial Pueblo y Educación.

de Armas Ramírez, N., & Valle Lima, A. (2011). *Resultados científicos en la investigación educativa.* Editorial Pueblo y Educación.

de la Herrán Gascón, A., Hurtado Fernández, M., & García Sempere, P. (2018). *Educación prenatal y Pedagogía prenatal: Nuevas perspectivas para la investigación, la enseñanza y la formación* (J. C. Arboleda Aparicio, Ed. Primera edición: ed., Vol. TOMO 1). Editorial REDIPE.

Escalona Vázquez I. (2018) La interdisciplinariedad: algunas consideraciones desde la carrera Licenciatura en Educación Preescolar. *Maestro y sociedad*, Número Especial 4 https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/3905

Fernández Pérez de Alejo, G. (2008a). *Atención a los niños con necesidades educativas especiales en el área del lenguaje en Cuba*. Pueblo y Educación.

Fernández Pérez de Alejo, G. (2008b). *La Atención Logopédica en la Edad Infantil.* Editorial Pueblo y Educación.

Fernández Pérez de Alejo, G., & Huepp Ramos, F. (2014). *Fundamentos neuropsicológicos del lenguaje*. Editorial Pueblo y Educación.

Fernández Pérez de Alejo, G. (2009). *Prevención y atención integral a los niños de 0 a 6 años con necesidades educativas especiales. Curso 28. Pedagogía 2009*.

Fiallo Rodríguez, J. (2004). La interdisciplinariedad: un concepto "muy conocido". In M. Álvarez Pérez (Ed.), *Interdisciplinariedad: Una aproximación desde la enseñanza aprendizaje de las ciencias* (pp. 20-36). Editorial Pueblo y Educación.

Fusté, M (1994). *La orientación que brinda la escuela a la familia para la realización de su labor educativa*. Editorial Pueblo y Educación.

García García, L. M., Charrasquiel Ortiz, M., Flórez Monterroza, Y. L., Palencia Pérez, L. M., Santodomingo, F. J., & Serpa Rivera, Y. d. J. (2008). Prácticas sobre estimulación prenatal que realizan las gestantes adultas asistentes al control prenatal en Sincelejo (Colombia). *Salud Uninorte*, 24(1), 31-39.

García de la Figal Costales, A. E. (2016). *Teoría y metodología de la investigación científica.* Editorial Universitaria Félix Varela.

Gartner, L. P., & Hiatt, J. L. (2008). *Atlas de Histología*. McGraw Hill.

González, H. (2014). *La terapia de los colores y las fragancias para la comunicación intrauterina*. (Tesis de especialidad). Valladolid: Universidad Miguel de Cervantes.

Hernández, K. (2016). La estimulación prenatal: Evolución y beneficios. *Universidad Católica de El Salvador/Anuario de Investigación*, 5 (361), 361-376.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). *Metodología de la investigación*. McGRAW-HILL

Huaylla Fuertes, G. I. (2021). Programa educativo de estimulación prenatal para el desarrollo cognitivo y sensorial en Potosí. *Revista Ecuatoriana de Psicología*, 4(8), 29 - 39. https://doi.org/https://doi.org/10.33996/repsi.v4i8.49

Huepp Ramos, F. L., & Fornaris Méndez, M. (2020). Estimulación temprana a niños con factores de riesgo de retraso mental. *Medisur [revista en Internet]*, *18*(1), 30-40. http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/4314

Huepp Ramos, F. L., & Fornaris Méndez, M. (2021). La estimulación temprana para el desarrollo infantil. *EduSol* vol.21 no.77. Epub 18-Oct-2021

Iliasov, I. I., & Liaudis, V. Y. (1986). *Antología de la Psicología Pedagógica y de las Edades.* Editorial Pueblo y Educación. Le Boulch, J. (2000). *Consideraciones sobre el crecimiento y desarrollo del feto*. Barcelona, España: Editorial Paidos

López, L. (2012). La importancia de la interdisciplinariedad en la construcción del conocimiento desde la filosofía de la educación. Sophia, *Colección de Filosofía de la Educación*(13), 367-377.

López Ornat, S. (2011). La adquisición del lenguaje, un resumen en 2011. *Revista de Investigación en Logopedia*, 1(1), 1-11. https://revistas.ucm.es/index.php/RLOG/article/view/58704/52880

Mayor, F. (1997). *El Correo de la UNESCO*, (Francia), Año L, noviembre de, p. 39

Moya Silvera, O., Santos Muñoz, D., Franco García, M. E., Ruíz Hernández, A., & Pérez Pérez, G. (2019). Una mirada a la comunicación intrauterina desde el currículo propio de la carrera de licenciatura en educación logopedia de la Universidad de Cienfuegos. *Conrado*, 15(supl.1).

Muñoz Verdezoto, P., Bodero Arízaga, L., Salvador Brito, J., & González Orbea, G. (2018). Bases teóricas de la interdisciplinariedad para la formación científico-investigativa de los estudiantes universitarios. *Revista Lasallista de Investigación*, 15 (2). https://doi.org/DOI: 10.22507/rli.v15n2a26

Nocedo de León, I., Catellanos Simons, B., García Batista, G., Addine Fernández, F., González Dosil, C., Gort Sánchez, M., Ruiz Aguilera, A., Minujín Zmud, A. F., & Valera Alfonso, O. (2001). *Metodología de la investigación educacional. Segunda Parte.* Pueblo y Educación.

Pérez Rodríguez, G., García Batista, G., Nocedo de León, I., & García Inza, M. L. (2009). *Metodología de la investigación educacional. Primera parte*. Editorial Pueblo y Educación.

Oates, J., Karmiloff, A., & Johnson, M. (2012). El cerebro en desarrollo. Reino Unido: Cambrian Printers

Oates, J., Karmiloff, A., & Johnson, M. (2012). El cerebro en desarrollo. Reino Unido: Cambrian Printers.

Paricio Andrés, D. (2019). *Estimulación prenatal.* Universidad de Valencia. Facultad de Psicología Retrieved 19 de noviembre from http://mural.uv.es/diapan/

Ramos, F., & Gualpa, C. (2011). Técnicas de estimulación prenatal como estrategia para el desarrollo socio afectivo del neonato. MILAGRO: Universidad Estatal de Milagro.

Reyes Gómez, U., Hernández Rico, M. P., Reyes Hernández, D., Javier Hernández, L., & Ortiz Martínez, M. (2006). La música de Mozart en el periodo prenatal. *Ginecología y Obstetricia de México*, 74(8), 424-428.

Rodrigo Moriche, M. P. (2018). Una mirada interdisciplinar para la educación prenatal: Centros de atención primaria, escuelas infantiles y familias. In J. C.

Arboleda Aparicio (Ed.), *Educación prenatal y Pedagogía prenatal: Nuevas perspectivas para la investigación, la enseñanza y la formación.* (Vol. 1, pp. 56-78). Editorial REDIPE.

Rosero Armijos, C., Pinos Robalino, P., & Segovia Palma, P. (2017). La interdisciplinariedad desde la asignatura de Histología General y Dentaria en la carrera de Odontología. *Universidad y Sociedad* [seriada en línea], 9(1), 137-142. http://rus.ucf.edu.cu/

Sierra Salcedo, R. A., & Caballero Delgado, E. (2009). *Selección de lecturas de metodología de la investigación educativa*. Editorial Pueblo y Educación.

Tamayo y Tamayo, M. (2014). La *interdisciplinariedad*. ICESI.

Terré, O. (2005). Técnicas para la Estimulación Sensorial de madres embarazadas y niños en edad temprana. Manual Práctico La Paz: Formas.

Torres, M. (2004). Familia, Unidad y Diversidad, Editorial Pueblo y Educación.

Vallejo, L. (2013). Estimulación Prenatal. Quito: ITSCO.

Vargas, R. (2010). Desarrollo Infantil. Recuperado de http://desainfa1rvr.blogspot.com/2009/10/buena.htm

Vigotsky, L. S. (1982). *Pensamiento y lenguaje*. Editorial Pueblo y Educación.

Vigotsky, L. S. (1987). *Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores.* Editorial Científico Técnica.

Villacorta, E. (2004). Bebé sano. Recuperado de http://www.geocities.com/bebesano/neoestimu.htm

Anexo 1

Guía de entrevista a Médicos y Enfermeras del Consultorio de Medico de la Familia

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento que presentan acerca de la estimulación del lenguaje en la etapa gestacional

Estimado compañero(a): con el fin de contribuir a una mejor atención a gestantes y un desarrollo comunicativo positivo del futuro niño le solicitamos su valiosa cooperación, respondiendo con la mayor sinceridad posible las interrogantes que se muestran a continuación.

1. ¿Cuántas gestantes tiene su consultorio?
2. ¿A cuántas gestantes se le aplica técnicas de estimulación de la comunicación oral en la etapa gestacional?
3. ¿Posee algún conocimiento previo para ejercer esta actividad?
4. Participa en algún tipo de preparación o capacitación para desarrollar esta actividad.
5. ¿Cuáles son los motivos que le impiden ejercer esta actividad?
6. ¿Conoce usted los beneficios de la estimulación prenatal para la gestante y su futuro niño?

a) En caso de ser positiva la respuesta, mencione algunas de ellas.

ANEXO 2 Guía de entrevista promotores del programa Educa a tu hijo que laboran en el Poblado Siboney.

Objetivo: Determinar el conocimiento y aplicación de la estimulación de la comunicación oral en la etapa gestacional.

Estimado compañero(a): con el fin de contribuir a la atención a embarazadas en el tema de estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal, solicitamos su valiosa cooperación, respondiendo con la mayor sinceridad posible las interrogantes que se muestran a continuación.

1. ¿Conoce usted acerca de la estimulación prenatal de la comunicación oral?
2. ¿La aplica en su labor?
3. ¿Posee algún conocimiento de las técnicas que se pueden aplicar?
4. Participa en algún tipo de preparación o capacitación para desarrollar su actividad.
5. ¿Puede mencionar algunas?
6. ¿Conoce usted sus beneficios?

a) En caso de ser positiva la respuesta, mencione algunos de ellos.

7. ¿Conoce cuáles pueden ser las causas de el por qué no se aplican?
8. ¿Dentro de su labor se encuentra estipulada la estimulación prenatal de la comunicación oral?
9. ¿Tienen en su poder bibliografía que aborde el tema?

Anexo 3 Guía de Análisis de documentos.

Objetivo: Constatar si se realizan acciones para desarrollar la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal.

Documentos: Manual del Médico y Enfermera.

Indicadores:

Desarrollo de acciones para la estimulación de la comunicación oral en la etapa prenatal.

Conocimiento que posee el profesional sobre la temática.

Anexo 4

Guía de Entrevista a gestantes

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento que presentan acerca de la estimulación del lenguaje en la etapa gestacional.

1. ¿Conoce en que consiste la estimulación de la comunicación oral en la etapa gestacional?
2. ¿Se le ha realizado alguna técnica de estimulación prenatal?
3. ¿A recibido alguna preparación o capacitación a cerca del tema?
4. ¿Le gustaría participar en estas actividades de estimulación prenatal?
5. ¿Conoce usted los beneficios de la estimulación prenatal para la gestante y su futuro niño?

Anexo 5

ENCUESTA PARA LA CONSULTA A EXPERTOS.

Objetivo: Determinar la competencia de los expertos en el conocimiento que poseen acerca de la estimulación del lenguaje en la etapa gestacional.

Estimado(a) colega, este es el cuestionario para su autoevaluación como posible experto sobre el tema que se investiga.

Si tuviera que decidir sobre una escala creciente de 0 a 10 el conocimiento que usted posee sobre la estrategia para la estimulación prenatal. ¿Dónde usted se ubicaría?

Desconocimiento Conocimiento

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ka es el coeficiente de argumentación o fundamentación.

2- Autovalore el grado de influencia que cada una de las fuentes presentadas a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterios acerca del tema acerca de la estimulación de la comunicación oral en la etapa gestacional.

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN	Grado de influencia de cada fuente.		
	ALTO	MEDIO	BAJO
I. Conocimiento sobre la estimulación de la comunicación oral en la etapa gestacional como resultado de estudios realizados o producto de su autopreparación			
II. Experiencia sobre la estimulación de la comunicación oral en la etapa gestacional.			
III. Conocimiento del estado actual de la estimulación de la comunicación oral en la etapa gestacional en cuba.			
IV: Análisis de trabajos de autores extranjeros sobre la estimulación de la comunicación oral en la etapa gestacional.			
V. Conocimiento del estado de la estimulación de la comunicación oral en la etapa gestacional en el extranjero.			
VI. Visión sobre el perfeccionamiento de la estimulación de la comunicación oral en la etapa gestacional.			

Anexo 6.

Encuesta del nivel de conocimiento.

Escala valorativa aplicada a los expertos en relación con el dominio que poseen del tema. Kc.

Experto	Niveles en que se evalúan su conocimiento los expertos seleccionados.									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1									x	
2									x	
3										x
4										x
5										x
6								X		
7										x
8									x	
9								X		
10									x	

Anexo 7.

Resultado de la encuesta de argumentación.

DAR SOLO VALORES 1, 2, 3 SEGÚN ALTO, MEDIO, BAJO.

	FUENTES DE ARGUMENTACIÓN				□	
EXPERTO #	**F1**	**F2**	**F3**	**F4**	**F5**	**F6**
1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	3	1	2
3	2	2	1	2	1	1
4	3	1	1	2	1	1
5	1	1	1	1	3	1
6	1	2	1	1	3	3
7	1	1	1	1	2	2
8	1	1	1	1	1	2
9	1	1	1	1	1	1
10	1	1	2	1	1	1

Anexo 8.

Resultado de la selección de expertos.

EXPERTO #	KC	KA	K		F1	F2	F3	F4	F5	F6
1	0,9	0,72	0,81	COMPETENCIA ALTA	0,13	0,13	0,14	0,1	0,12	0,1
2	0,9	0,65	0,775	COMPETENCIA ALTA	0,13	0,13	0,14	0,05	0,12	0,08
3	1	0,648	0,824	COMPETENCIA ALTA	0,104	0,104	0,14	0,08	0,12	0,1
4	1	0,6355	0,8175	COMPETENCIA ALTA	0,065	0,13	0,14	0,08	0,12	0,1
5	1	0,66	0,83	COMPETENCIA ALTA	0,13	0,13	0,14	0,1	0,06	0,1
6	0,8	0,584	0,692	COMPETENCIA ALTA	0,13	0,104	0,14	0,1	0,06	0,05
7	1	0,676	0,838	COMPETENCIA ALTA	0,13	0,13	0,14	0,1	0,096	0,08
8	0,9	0,7	0,8	COMPETENCIA ALTA	0,13	0,13	0,14	0,1	0,12	0,08
9	0,8	0,72	0,76	COMPETENCIA ALTA	0,13	0,13	0,14	0,1	0,12	0,1
10	0,9	0,692	0,796	COMPETENCIA ALTA	0,13	0,13	0,112	0,1	0,12	0,1

Anexo 9.

Encuesta a expertos.

Objetivo: valorar por los expertos el manual para la estimulación de la comunicación oral en la etapa gestacional.

Compañero (a):

Para realizar una investigación encaminada a elaborar un manual para la estimulación de la comunicación oral en la etapa gestacional. Le ponemos a su consideración la valoración del mismo.

Otórguele, según su opinión, una categoría a cada ítem marcando con una X en la columna correspondiente. Las categorías son:

Muy adecuado (MA)

Bastante adecuado (BA)

Adecuado (A)

Poco adecuado (PA)

Inadecuado (I).

Necesitamos que nos remita sus criterios personales en cuanto a los siguientes

ASPECTOS A VALORAR MOMENTOS DE LA ESTRATEGIA	Escala valorativa				
	MA	BA	A	PA	I
1. Objetivo general del manual					
2. Estructura del manual					
3. Actividades que se desarrollan en el manual para la estimulación de la comunicación oral en la etapa gestacional.					
4. Trabajo con la interdisciplinariedad					
5. Trabajo con la estimulación de la comunicación.					

Anexo 10.

Resultados de la evaluación de los expertos de la estrategia.

	Cantidad de expertos:		10			
	Cantidad de pasos:		5			
	Número de categorías		5			
PASOS	Muy adecuado	Bastante adecuado	Adecuado	Poco adecuado	No adecuado	TOTAL
P1	10					10
P2	1	7	2			10
P3	1	8	1			10
P4		7	3			10
P5		6	4			10